

医学源流论

徐大椿

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
原序	6
卷上	7
卷下	30

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

《医学源流论》二卷，国朝徐大椿撰。其大纲凡七，曰经络脏腑，曰脉，曰病，曰药，曰治法，曰书论，曰古今。分子目九十有三。持论多精凿有据。如谓病之名有万，而脉之象不过数十种，是必以望、闻、问三者参之。又如病同人异之辨，兼证兼病之别，亡阴亡阳之分，病有不愈不死，有虽愈必死，又有药误不即死，药性有今古变迁，《内经》司天运气之说不可泥，针灸之法失传。其说皆可取。而人参论一篇，涉猎医书论一篇，尤深切著明。至於有欲救俗医之弊而矫枉过直者，有求胜古人之心而大言失实者，故其论病则自岐黄以外，秦越人亦不免诋排。其论方则自张机《金匱要略》、《伤寒论》之外，孙思邈、刘守真、李杲、朱震亨皆遭驳诘。於医学中殆同毛奇龄之《说经》。然其切中庸医之弊者，不可废也。

原序

醫，小道也，精義也，重任也，賤工也。古者大人之學，將以治天下國家，使無一夫不被其澤，甚者天地位而萬物育，斯學者之極功也。若夫日救一人，月治數病，顧此失彼，雖數十里之近，不能兼及。況乎不可治者，有非使能起死者而使之生，其道不已小乎？雖然，古聖人之治病也，通於天地之故，究乎性命之源，經絡、臟腑、氣血、骨脈，洞然如見，然後察其受病之由，用藥以驅除而調劑之。其中自有玄機妙悟，不可得而言喻者，蓋與造化相維，其義不亦精乎？道小，則有志之士有所不屑為，義精，則無識之突有所不能窺也。人之所系，莫大乎生死。王公大人，聖賢豪傑，可以旋轉乾坤，而不能保無疾病之患。一有疾病，不得不聽之醫者，而生殺唯命矣。夫一人係天下之重，而天下所係之人，其命由懸於醫者。下而一國一家所係之人更無論矣，其任不亦重乎？而獨是其人者，又非有爵祿道德之尊，父兄師保之重。既非世之所隆，而其人之自視，亦不過為衣服口食之計。雖以一介之微，呼之而立，至其業不甚賤乎？任重，則托之者必得傳人；工賤，則業之者必無奇士。所以勢出於相違，而道因之易墜也。余少時頗有志於窮經，而骨肉數人疾病連年，死亡略盡。於是博覽方書，寢食俱廢。如是數年，雖無生死骨肉之方，實有尋本溯源之學。九折臂而成醫，至今尤信。而竊慨唐宋以來，無儒者為之振興，視為下業，逡巡失傳，至理已失，良法併亡，惄然傷懷，恐自今以往，不復有生人之術。不揣庸妄，用敷厥言，倘有所補所全者，或不僅一人一世已乎？

乾隆丁丑年七月洄溪徐大椿書於五山之半松書屋

卷上

元氣存亡論

養生者之言曰：天下之人，皆可以無死。斯言妄也，何則？人生自免乳哺以後，始而孩，既而長，既而壯，日勝一日。何以四十以後，飲食奉養如昔，而日且就衰？或者曰：嗜慾戕之也。則絕嗜慾，可以無死乎？或者曰：勞動賊之也。則戒勞動，可以無死乎？或者曰：思慮擾之也。則屏思慮，可以無死乎？果能絕嗜慾，戒勞動，減思慮，免於疾病夭札則有之。其老而眊眊而死，猶然也。況乎四十以前，未嘗無嗜慾、勞苦、思慮，然而日生日長。四十以後，雖無嗜慾、勞苦、思慮，然而日減日消，此其故何歟？蓋人之生也，顧夏蟲而卻笑，以為是物之生死，何其促也，而不知我實猶是耳。當其受生之時，已有定分焉。所謂定分者，元氣也。視之不見，求之不得，附於氣血之內，宰乎氣血之先。其成形之時，已有定數。譬如置薪於火，始然尚微，漸久則烈，薪力既盡，而火熄矣。其有久暫之殊者，則薪之堅脆異質也。故終身無病者，待元氣之自盡而死，此所謂終其天年者也。至於疾病之人，若元氣不傷，雖病甚不死，元氣或傷雖病亦死，而其中又有辨焉。有先傷元氣而病者，此不可治者也；有因病而傷元氣者，此不可不預防者也。亦有因誤治而傷及元氣者，亦有元氣雖傷未甚，尚可保全之者，其等不一。故診病決死生者，不視病之輕重，而視元氣之存亡，則百不失一矣。至所謂元氣者，何所寄耶？五臟有五臟之真精，此元氣之分體者也。而其根本所在，即《道經》所謂丹田，《難經》所謂命門，《內經》所謂七節之旁，中有小心，陰陽闔闢存乎此，呼吸出入係乎此。無火而能令百體皆溫，無水而能令五臟皆潤。此中一線未絕，則生氣一線未亡，皆賴此也。若夫有疾病而保全之法何如？蓋元氣雖自有所在，然實與臟腑相連屬者也。寒熱攻補不得其道，則實其實而虛其虛，必有一臟大受其害。邪入於中，而精不能續，則元氣無所附而傷矣。故人之一身，無處不宜謹護，而藥不可輕試也。若夫預防之道，惟上工能慮在病前，不使其勢已橫而莫救，使元氣克全，則自能托邪於外。若邪盛為害，則乘元氣未動，與之背城而一決，勿使後事生悔，此神而明之之術也。若欲與造化爭權，而令天下之人終不死，則無是理矣。

軀殼經絡臟腑論

凡致病必有因，而受病之處則各有部位。今之醫者曰：病必分經絡而後治之。似矣，然亦知病固非經絡之所能盡者乎？夫人有皮肉筋骨以成形，所謂軀殼也。而虛其中，則有臟腑以實之。其連續貫通者，則有經有絡貫乎臟腑之內，運乎軀殼之中，為之道路，以傳變周流者也。故邪之傷人，或在皮肉，或在筋骨，或在臟腑，或在經絡。有相傳者，有不相傳者，有久而相傳者，有久而終不傳者。其大端則中於經絡者易傳；其初不在經絡，或病甚而流於經絡者亦易傳。經絡之病，深入臟腑，則

以生剋相傳。惟皮肉筋骨之病，不歸經絡者，則不傳，所謂軀殼之病也。故識病之人，當直指其病在何臟何腑，何筋何骨，何經何絡，或傳或不傳，其傳以何經始，以何經終。其言歷歷可驗，則醫之明者矣。今人不問何病，謬舉一經以藉口，以見其頗識《內經》，實與《內經》全然不解也。至治之難易，則在經絡者易治，在臟腑者難治，且多死。在皮肉筋骨者，難治，亦不易死，其大端如此。至於軀殼臟腑之屬於某經絡，以審其針灸用藥之法，則《內經》明言之，深求自得也。

表裏上下論

欲知病之難易，先知病之淺深。欲知病之淺深，先知病之部位。夫人身一也，實有表裏上下之別焉。何謂表？皮肉筋骨是也；何謂裏，臟腑精神是也。而經絡則貫乎其間。表之病，易治而難死；裏之病，難治而易死。此其大略也。而在表在裏者，又各有難易，此不可執一而論也。若夫病本在表而傳於裏，病本在裏而并及於表，是為內外兼病，尤不易治。身半已上之病，往往近於熱；身半已下之病，往往近於寒，此其大略也。而在上在下，又各有寒熱，此亦不可執一而論也。若夫病本在上而傳於下，病本在下而傳於上，是之謂上下兼病，亦不易治。所以然者，無病之處多，有病之處少，則精力猶可維持，使正氣漸充，而邪氣亦去。若夫一人之身，無處不病，則以何者為驅病之本，而復其元氣乎？故善醫者，知病勢之盛而必傳也。豫為之防，無使結聚，無使泛濫，無使併合，此上工治未病之說也。若其已至於傳，則必先求其本，後求其標，相其緩急而施治之。此又桑榆之收也。以此決病之生死難易，思過半矣。

陰陽升降論

人身象天地。天之陽藏於地之中者，謂之元陽。元陽之外護者，謂之浮陽，浮陽則與時升降。若人之陽氣，則藏於腎中，而四布於周身，惟元陽則固守於中而不離其位。故太極圖中心白圈，即元陽也，始終不動，其分陰分陽，皆在白圈之外。故發汗之藥，皆鼓動其浮陽，出於營衛之中，以洩其氣耳。若元陽一動，則元氣漓矣。是以發汗太甚，動其元陽，即有亡陽之患。病深之人發喘呃逆，即有陽越之虞，其危皆在頃刻，必用參附及重鎮之藥以墜安之。所以治元氣虛弱之人，用升提發散之藥，最防陽氣散越，此第一關也。至於陰氣則不患其升，而患其竭，竭則精液不布，乾枯燥烈，廉泉玉英，毫無滋潤，舌燥唇焦，皮膚粗槁。所謂天氣不降，地氣不升，孤陽無附，害不旋踵。《內經》云：「陰精所奉其人壽」故陰氣有餘則上溉，陽氣有餘則下固，其人無病，病亦易愈，反此則危。故醫人者，慎毋發其陽而竭其陰也。

治病必分經絡臟腑論

病之從內出者，必由於臟腑；病之從外入者，必由於經絡。其病之情狀，必有鑿鑿可徵者。如怔忡驚悸為心之病，洩瀉膨脹為腸胃之病，此易知者。又有同一寒熱而六經各殊，同一疼痛而筋骨皮肉各別。又有臟腑有病而反現於肢節，肢節有病而反現於臟腑。若不究其病根所在，而漫然治之，則此之寒熱，非彼之寒熱，此之痛癢，非彼之痛癢，病之所在，全不關著，無病之處，反以藥攻之。《內經》所謂：誅伐無過，則故病未已，新病復起。醫者以其反增他病，又復治其所增之病，復不知病之所從來，雜藥亂投，愈治而病愈深矣。故治病者，必先分經絡臟腑之所在，而又知其七情六淫所受何因，然後擇何經何臟對病之藥，本於古聖何方之法，分毫不爽，而後治之，自然一劑而即見效矣。今之治病不效者，不咎己藥之不當，而反咎病之不應藥，此理終身不悟也。

治病不必分經絡臟腑論

病之分經絡臟腑，夫人知之。於是天下遂有因經絡臟腑之說，而拘泥附會，又或誤認穿鑿，并有借此神其說以欺人者。蓋治病之法多端，有必求經絡臟腑者，有不求經絡臟腑者。蓋人之氣血無所不通，而藥性之寒熱溫涼有毒無毒，其性亦一定不移，入於人身，其功能亦無所不到，豈有其藥止入某經之理？即如參耆之類，無所不補；砒鴆之類，無所不毒，並不專於一處也。所以古人有現成通治之方，如紫金錠、至寶丹之類，所治之病甚多，皆有奇效。蓋通氣者無氣不通，解毒者無毒不解，消痰者無痰不消，其中不過略有專宜耳。至張潔古輩，則每藥註定云獨入某經，皆屬附會之談，不足徵也。曰：然則用藥竟不必分經絡臟腑耶？曰：此不然也。蓋人之病，各有所現之處，而藥之治病，必有專長之功。如柴胡治寒熱往來，能愈少陽之病；桂枝治畏寒發熱，能愈太陽之病；葛根治肢體大熱，能愈陽明之病。蓋其止寒熱，已畏寒，除大熱，此乃柴胡、桂枝、葛根專長之事。因其能治何經之病，後人即指為何經之藥，孰知其功能實不僅入少陽、太陽、陽明也。顯然者尚如此，餘則更無影響矣。故以某藥為能治某經之病則可，以某藥為獨治某經則不可；謂某經之病當用某藥則可，謂某藥不復入他經則不可。故不知經絡而用藥，其失也泛，必無捷效。執經絡而用藥，其失也泥，反能致害。總之，變化不一，神而明之，存乎其人也。

腎藏精論

精藏於腎，人盡知之。至精何以生？何以藏？何以出？則人不知也。夫精即腎中之脂膏也，有長存者，有日生者。腎中有藏精之處，充滿不缺，如井中之水，日夜充盈，此長存者也；其慾動交媾所出之精，及有病而滑脫之精，乃日生者也。其精旋去旋生，不去亦不生，猶井中之水，日日汲之，不見其虧，終年不汲，不見其溢。

《易》云：井道不可不革。故受之以革，其理然也。曰：然則縱慾可無害乎？曰：是又不然。蓋天下之理，總歸自然，有腎氣盛者，多慾無傷；腎氣衰者，自當節養。《左傳》云：女不可近乎？對曰：節之。若縱慾不節，如淺狹之井，汲之無度，則枯竭矣。曰：然則強壯之人而絕慾則何如？曰：此亦無咎無譽，惟腎氣略堅實耳。但必浮火不動，陰陽相守則可耳。若浮火日動而強制之，則反有害。蓋精因火動而離其位，則必有頭眩、目赤、身癢、腰疼、遺洩、偏墜等症，甚者或發癰疽，此強制之害也。故精之為物，慾動則生，不動則不生，能自然不動則有益。強制則有害，過用則衰竭，任其自然而無所勉強，則保精之法也。老子云：天法道，道法自然，自然之道，乃長生之訣也。

一臟一腑先絕論

人之死，大約因元氣存亡而決。故患病者，元氣已傷即變危殆。蓋元氣脫，則五臟六腑皆無氣矣。竟有元氣深固，其根不搖，而內中有一臟一腑先絕者。如心絕則昏昧不知世事，肝絕則喜怒無節，腎絕則陽道痿縮，脾絕則食入不化，肺絕則氣促聲啞。六腑之絕，而失其所司亦然，其絕之象，亦必有顯然可見之處。大約其氣尚存，而神志精華不用事耳，必明醫乃能決之。又諸臟腑之中，惟肺絕則死期尤促。蓋肺為臟腑之華蓋，臟腑賴其氣以養，故此臟絕則臟腑皆無稟受矣，其餘則視其絕之甚與不甚。又觀其別臟之盛衰何如，更觀其後天之飲食何如，以此定其吉凶，則修短之期可決矣。然大段亦無過一年者，此皆得之目睹，非臆說也。

君火相火論

近世之論心火謂之君火，腎火謂之相火，此說未安。蓋心屬火而位居於上，又純陽而為一身之主，名曰君火，無異議也。若腎中之火，則與心相遠，乃水中之火也，與心火不類，名為相火，似屬非宜。蓋陰陽互藏其宅，心固有火，而腎中亦有火。心火為火中之火，腎火為水中之火。腎火守於下，心火守於上，而三焦為火之道路，能引二火相交。心火動則腎中之浮火亦隨之，腎火動而心中之浮火亦隨之；亦有心火動而腎火不動，其患獨在心，亦有腎火動而心火不動，其害獨在腎。故治火之法，必先審其何火，而後用藥有定品。治心火以苦寒，治腎火以鹹寒。若二臟之陰不足以配火，則又宜取二臟之陰藥補之。若腎火飛越，又有回陽之法，反宜用溫熱

，與治心火迥然不同。故五臟皆有火，而心腎二臟為易動，故治法宜詳究也。若夫相火之說，則心胞之火能令人怔忡，面赤煩躁眩暈，此則在君火之旁，名為相火，似為確切，試以《內經》參之，自有真見也。

診脈決死生論

生死於人大矣！而能於兩手方寸之地微末之動，即能決其生死，何其近於誣也。然古人往往百不失一者何哉？其大要則以胃氣為本。蓋人之所以生，本乎飲食。靈樞云：穀入於胃，乃傳之肺，五臟六腑，皆以受氣。寸口屬肺經，為百脈之所會。故其來也，有生氣以行乎其間，融和調暢，得中土之精英。此為有胃氣得者生，失者死，其大較也。其次則推天運之順逆，人氣與天氣相應。如春氣屬木，脈宜弦；夏氣屬火，脈宜洪之類，反是則與天氣不應。又其次則審臟氣之生剋。如脾病畏弦，木剋土也；肺病畏洪，火剋金也，反是則與臟氣無害。又其次則辨病脈之從違，病之與脈，各有宜與不宜。如脫血之後，脈宜靜細，而反洪大，則氣亦外脫矣；熱寒之症，脈宜洪數，而反細弱，則真元將陷矣。至於真臟之脈，乃因胃氣已絕，不營五臟。所以何臟有病，則何臟之脈獨現，凡此皆《內經》、《難經》等書言之，明白詳盡。學者苟潛心觀玩，洞然易曉，此其可決者也。至云診脈即可以知何病，又云：人之死生，無不能先知，則又非也。蓋脈之變遷無定，或有卒中之邪，未即通於經絡，而脈一時未變者；或病輕而不能現於脈者；或有沉痼之疾，久而與氣血相併，一時難辨其輕重者；或有依經傳變，流動無常，不可執一時之脈，而定其是非者。況病之名有萬，而脈之象不過數十種，且一病而數十種之脈無不可見，何能診脈而即知其何病？此皆推測偶中，以此欺人也。若夫真臟之脈，臨死而終不現者，則何以決之？是必以望聞問三者，合而參觀之，亦百不失一矣。故以脈為可憑，而脈亦有時不足憑；以脈為不可憑，而又鑿鑿乎其可憑。總在醫者熟通經學，更深思自得，則無所不驗矣。若世俗無稽之說，皆不足聽也。

症脈輕重論

人之患病，不外七情六淫，其輕重死生之別，醫者何由知之？皆必問其症，切其脈而後知之。然症脈各有不同，有現症極明而脈中不見者，有脈中甚明而症中不見者。其中有宜從症者，有宜從脈者，必有一定之故。審之既真，則病情不能逃，否則不為症所誤，必為脈所誤矣。故宜從症者，雖脈極順而症危，亦斷其必死；宜從脈者，雖症極險而脈和，亦決其必生。如脫血之人，形如死狀，危在頃刻，而六脈有根則不死，此宜從脈不從症也。如痰厥之人，六脈或促或絕，痰降則愈，此宜從症不從脈也。陰虛咳嗽，飲食起居如常，而六脈細數，久則必死，此宜從脈不宜從症

也。噎膈反胃，脈如常人，久則胃絕而脈驟變，百無一生，此又宜從症不從脈也。如此之類甚多，不可枚舉。總之，脈與症分觀之，則吉凶兩不可憑；合觀之，則某症忌某脈，某脈忌某症，其吉凶乃可定矣。又如肺病忌脈數，肺屬金，數為火，火刑金也，餘可類推，皆不外五行生剋之理。今人不按其症，而徒講乎脈，則講之愈密，失之愈遠。若脈之全體，則《內經》諸書詳言之矣。

脈症與病相反論

症者，病之發現者也。病熱則症熱，病寒則症寒，此一定之理。然症竟有與病相反者，最易誤治，此不可不知者也。如冒寒之病，反身熱而惡熱；傷暑之病，反身寒而惡寒；本傷食也，而易飢能食；本傷飲也，而反大渴口乾。此等之病，尤當細考，一或有誤，而從症用藥，即死生判矣。此其中蓋有故焉，或一時病勢未定。如傷寒本當發熱，其時尚未發熱，將來必至於發熱，此先後之不同也；或內外異情，如外雖寒而內仍熱是也；或有名無實，如欲食好飲，及至少進即止，飲食之後又不易化是也；或有別症相雜，誤認此症為彼症是也；或此人舊有他病，新病方發，舊病亦現是也。至於脈之相反，亦各不同。或其人本體之脈與常人不同；或輕病未現於脈；或痰氣阻塞，營氣不利，脈象乖其所之；或一時為邪所閉，脈似危險，氣通即復；或其人本有他症，仍其舊症之脈。凡此之類，非一端所能盡，總宜潛心體認，審其真實，然後不為脈症所惑。否則徒執一之見，用藥愈真，而愈誤矣。然苟非辨症極精，脈理素明，鮮有不惑者也。

中風論

今之患中風偏痺等病者，百無一愈，十死其九，非其症俱不治，皆醫者誤之也。凡古聖定病之名，必指其實。名曰中風，則其病屬風可知。既為風病，則主病之方必以治風為本。故仲景侯氏黑散、風引湯、防己地黃湯，及唐人大小續命等方，皆多用風藥，而因症增減。蓋以風入經絡，則內風與外風相煽，以致痰火一時壅塞，惟宜先驅其風，繼清痰火，而後調其氣血，則經脈可以漸通。今人一見中風等症，即用人參、熟地、附子、肉桂等純補溫熱之品，將風火痰氣盡行補住，輕者變重，重者即死。或有元氣未傷，而感邪淺者，亦必遷延時日，以成偏枯永廢之人，此非醫者誤之耶？或云：邪之所湊，其氣必虛，故補正即所以驅邪，此大繆也。惟其正虛而邪湊，尤當急驅其邪以衛其正，若更補其邪氣，則正氣益不能支矣。即使正氣全虛，不能托邪於外，亦宜於驅風藥中，少加扶正之品，以助驅邪之力，從未有純用溫補者。譬之盜賊入室，定當先驅盜賊，而後固其牆桓，未有盜賊未去，而先固其牆桓者。或云補藥托邪，猶之增家人以御盜也，是又不然。蓋服純補之藥，斷無專

補正不補邪之理，非若家人之專於禦盜賊也，是不但不驅盜，并助盜矣。況治病之法，凡久病屬虛，驟病屬實。所謂虛者，謂正虛也；所謂實者，謂邪實也。中風乃急暴之症，其為實邪無疑。天下未有行動如常，忽然大虛而昏仆者，豈可不以實邪治之哉？其中或有屬陰虛陽虛，感熱感寒之別，則於治風方中，隨所現之症加減之。漢唐諸法具在，可取而觀也。故凡中風之類，苟無中臟之絕症，未有不可治者。余友人患此症者，遵余法治病，一二十年而今尚無恙者甚多，惟服熱補者，無一存者矣。

臆膈論

臆膈同為極大之病，然臆可治而膈不可治。蓋臆者有物積中，其症屬實，膈者不能納物，其症屬虛。實者可治，虛者不可治，虛其常也。臆之為病，因腸胃衰弱不能運化，或痰或血，或氣或食，凝結於中，以致膨脹滿。治之當先下其結聚，然後補養其中氣，則腸胃漸能剋化矣。《內經》有雞矢醴方，即治法也。後世治臆之方，亦多見效，惟臆氣已絕，臂細臍凸，手心及背平滿，青筋繞腹，種種惡症齊現則不治。若膈症乃肝火犯胃，木來侮土，謂之賊邪。胃脘枯槁不復用事，惟留一線細竅，又為痰涎瘀血閉塞，飲食不能下達，即勉強納食，仍復吐出。蓋人生全在飲食，經云：穀入於胃，以傳於肺，五臟六腑，皆以受氣。今食既不入，則五臟六腑皆竭矣。所以得此症者，能少納穀，則不出一年而死；全不納穀，則不出半年而死。凡春得病者，死於秋；秋得病者，死於春，蓋金木相剋之時也。又有卒然嘔吐，或嘔吐而時止時發，又或年當少壯，是名反胃，非膈也，此亦可治。至於類臆之症，如浮腫水腫之類，或宜針灸，或宜洩瀉，病象各殊，治亦萬變。醫者亦宜廣求諸法，而隨宜施用也。

寒熱虛實真假論

病之大端，不外乎寒熱虛實，然必辨其真假而後治之無誤。假寒者，寒在外而熱在內也，雖大寒而惡熱飲；假熱者，熱在外而寒在內也，雖大熱而惡寒飲，此其大較也。假實者，形實而神衰，其脈浮洪芤散也；假虛者，形衰而神全，其脈靜小堅實也。其中又有人之虛實，症之虛實。如怯弱之人而傷寒傷食，此人虛而症實也；強壯之人而失血勞倦，此人實而症虛也。或宜正治，或宜從治，或宜分治，或宜合治，或宜從本，或宜從標，寒因熱用，熱因寒用，上下異方，煎丸異法，補中兼攻，攻中兼補，精思妙術，隨變生機，病勢千端，立法萬變。則真假不能惑我之心，亦不能窮我之術。是在博求古法而神明之，稍執己見，或學力不至，其不為病所惑者幾希矣。

內傷外感論

七情所病，謂之內傷；六淫所侵，謂之外感。自《內經》、《難經》以及唐宋諸書，無不言之，深切著明矣。二者之病，有病形同而病因異者，亦有病因同而病形異者；又有全乎外感，全乎內傷者；更有內傷兼外感，外感兼內傷者。則因與病又互相出入，參錯雜亂，治法迥殊。蓋內傷由於神志，外感起於經絡，輕重淺深，先後緩急，或分或合，一或有誤，為害非輕。能熟於《內經》及仲景諸書，細心體認，則雖其病萬殊，其中條理井然，毫無疑似，出入變化，無有不效。否則徬徨疑慮，雜藥亂投，全無法紀，屢試不驗，更無把握。不咎己之審病不明，反咎藥之治病不應，如此死者，醫殺之耳。

病情傳變論

病有一定之傳變，有無定之傳變。一定之傳變，如傷寒太陽傳陽明，及金匱見肝之病，知肝傳脾之類。又如痞病變臌，血虛變浮腫之類，醫者可豫知而防之也。無定之傳變，或其人本體先有受傷之處；或天時不和，又感時行之氣；或調理失宜，更生他病，則無病不可變，醫者不能豫知而為防者也。總之，人有一病，皆當加意謹慎，否則病後增病，則正虛而感益重，輕病亦變危矣。至於既傳之後，則標本緩急，先後分合，用藥必兩處兼顧，而又不雜不亂，則諸病亦可漸次平復。否則新病日增，無所底止矣。至於藥誤之傳變，又復多端；或過於寒涼而成寒中之病；或過服溫燥而成熱中之病；或過於攻伐而元氣大虛；或過於滋潤而脾氣不實，不可勝舉。近日害人最深者，大病之後，邪未全退，又不察病氣所傷何處，即用附子、肉桂、熟地、麥冬、人參、白朮、五味、萸肉之類，將邪火盡行補瀆。始若相安，久之氣逆痰升，脹滿昏沉，如中風之狀，邪氣與元氣相併，諸藥無效而死。醫家病家，猶以為病後大虛所致，而不知乃邪氣固結而然也。余見甚多，不可不深戒。

病同人異論

天下有同此一病，而治此則效，治彼則不效，且不惟無效，而反有大害者，何也？則以病同而人異也。夫七情六淫之感不殊，而受感之人各殊。或氣體有強弱，質性有陰陽，生長有南北，性情有剛柔，筋骨有堅脆，肢體有勞逸，年力有老少，奉養有膏粱藜藿之殊，心境有憂勞和樂之別。更加天時有寒暖之不同，受病有深淺之各異。一概施治，則病情雖中，而於人之氣體迥乎相反，則利害亦相反矣。故醫者必

細審其人之種種不同，而後輕重緩急大小先後之法因之而定。《內經》言之極詳，即針灸及外科之治法盡然，故凡治病者，皆當如是審察也

病症不同論

凡病之總者，謂之病。而一病必有數症，如太陽傷風，是病也；其惡風身熱自汗頭痛，是症也。合之而成其為太陽病，此乃太陽病之症也。若太陽病，而又兼泄瀉不寐心煩痞悶，則又為太陽病之兼症矣。如瘧病也，往來寒熱嘔吐畏風口苦，是症也。合之而成為瘧，此乃瘧之本症也。若瘧而兼頭痛脹滿嗽逆便閉，則又為瘧疾之兼症矣。若瘧而又下痢數十行，則又不得謂之兼症，謂之兼病。蓋瘧為一病，痢又為一病，而二病又各有本症，各有兼症，不可勝舉。以此類推，則病之與症，其分併何啻千萬？不可不求其端而分其緒也。而治之法，或當合治，或當分治，或當先治，或當後治，或當專治，或當不治。尤在視其輕重緩急，而次第奏功。一或倒行逆施，雜亂無紀，則病變百出，雖良工不能挽回矣。

病同因別論

凡人之所苦謂之病，所以致此病者謂之因。如同一身熱也，有風有寒有痰有食，有陰虛火升，有鬱怒憂思，勞怯蟲症，此謂之因。知其因，則不得專以寒涼治熱病矣。蓋熱同而所以致熱者不同，則藥亦迥異。凡病之因不同，而治各別者盡然，則一病而治法多端矣。而病又非止一症，必有兼症焉。如身熱而腹痛，則腹痛又為一症。而腹痛之因又復不同，有與身熱相合者，有與身熱各別者。如感寒而身熱，其腹亦因寒而痛，此相合者也；如身熱為寒，其腹痛又為傷食，則各別者也。又必審其食為何食，則以何藥消之。其立方之法，必切中二者之病源，而後定方，則一藥而兩病俱安矣。若不問其本病之何因，及兼病之何因，而徒曰某病以某方治之。其偶中者，則投之或愈，再以治他人，則不但不愈，而反增病。必自疑曰：何以治彼效，而治此不效，并前此之何以愈亦不知之。則倖中者甚少，而誤治者甚多，終身治病而終身不悟，歷症愈多而愈惑矣。

亡陰亡陽論

經云：奪血者無汗，奪汗者無血。血屬陰，是汗多乃亡陰也。故止汗之法，必用涼心斂肺之藥何也？心主血，汗為心之液，故當清心火。汗必從皮毛出，肺主皮毛，

故又當斂肺氣，此正治也。惟汗出太甚，則陰氣上竭，而腎中龍雷之火隨水而上。若以寒涼折之，其火愈熾。惟用大劑參附，佐以鹹降之品，如童便、牡蠣之類，冷飲一〔木宛〕，直達下焦，引其真陽下降，則龍雷之火反乎其位，而汗隨止。此與亡陰之汗，真大相懸絕。故亡陰亡陽，其治法截然，而轉機在頃刻。當陽氣之未動也，以陰藥止汗，及陽氣之既動也，以陽藥止汗。而龍骨牡蠣、黃耆、五味收澀之藥，則兩方皆可隨宜用之。醫者能於亡陰亡陽之交，分其界限，則用藥無誤矣。其亡陰亡陽之辦法何如？亡陰之汗，身畏熱，手足溫，肌熱汗亦熱而味鹹，口渴喜涼飲，氣粗，脈洪實，此其驗也。亡陽之汗，身反惡寒，手足冷，肌涼汗冷，而味淡微粘，口不渴而喜熱飲，氣微，脈浮數而空，此其驗也。至於尋常之正汗、熱汗、邪汗、自汗，又不在二者之列，此理知者絕少，即此汗之一端，而聚訟紛紛，毫無定見，誤治甚多也。註：〔木宛〕，組合字，音“碗”，為“小孟”之義。

病有不愈不死雖愈必死論

能愈病之非難，知病之必愈必不愈為難。夫人之得病，非皆死症也。庸醫治之，非必皆與病相反也。外感內傷，皆有現症，約略治之，自能向愈，況病情輕者，雖不服藥亦能漸痊，即病勢危迫，醫者苟無大誤，邪氣漸退，亦自能向安，故愈病非醫者之能事也。惟不論輕重之疾，一見即能決其死生難易，百無一失，此則學問之極功，而非淺嘗者所能知也。夫病輕而預知其愈，病重而預知其死，此猶為易知者。惟病象甚輕，而能決其必死，病勢甚重，而能斷其必生，乃為難耳。更有病已愈而不久必死者。蓋邪氣雖去，而其人之元氣與病俱亡，一時雖若粗安，真氣不可復續。如兩虎相角，其一雖勝，而力已脫盡，雖良工亦不能救也。又有病必不愈而人亦不死者。蓋邪氣盛而元氣堅固，邪氣與元氣相併，大攻則恐傷其正，小攻則病不為動，如油入麵，一合則不可復分，而又不至於傷生。此二者，皆人之所不知者也，其大端則病氣入臟腑者，病與人俱盡者為多，病在經絡骨脈者，病與人俱存者為多，此乃內外輕重之別也。斯二者，方其病之始形，必有可徵之端，良工知之，自有防微之法。既不使之與病俱亡，亦不使之終身不愈。此非深通經義之人，必不能窮源極流，挽回於人所不見之地也。

卒死論

天下卒死之人甚多，其故不一。內中可救者，十之七八，不可救者，僅十之二三，惟一時不得良醫，故皆枉死耳。夫人內外無病，飲食行動如常，而忽然死者，其臟腑經絡本無受病之處，卒然感犯外邪，如惡風穢氣鬼邪毒厲等物。閉塞氣道，一時不能轉動，則大氣阻絕。昏悶迷惑，久而不通，則氣愈聚愈塞，如繫繩於頸，氣絕

則死矣。若醫者能知其所犯何故，以法治之，通其氣，驅其邪，則立愈矣。又有痰涎壅盛，阻遏氣道而卒死者，通氣降痰則甦，所謂痰厥之類是也。以前諸項，良醫皆能治之，惟臟絕之症則不治。其人或勞心思慮，或酒食不節，或房慾過度，或惱怒不常，五臟之內，精竭神衰。惟一線真元未斷，行動如常，偶有感觸。其元氣一時斷絕，氣脫神離，頃刻而死，既不可救，又不及救，此則卒死之最急，而不可治者也。至於暴遇神鬼，適逢冤譴，此又怪異之事，不在疾病之類矣。

病有鬼神論

人之受邪也，必有受之之處，有以召之，則應者斯至矣。夫人精神完固，則外邪不敢犯，惟其所以禦之之具有虧，則侮之者斯集。凡疾病有為鬼神所憑者，其愚魯者，以為鬼神實能禍人；其明理者，以為病情如此，必無鬼神，二者皆非也。夫鬼神，猶風寒暑濕之邪耳。衛氣虛則受寒，榮氣虛則受熱，神氣虛則受鬼。蓋人之神屬陽，陽衰則鬼憑之，《內經》有五臟之病，則現五色之鬼。《難經》云：脫陽者見鬼。故經穴中有鬼床、鬼室等穴。此諸穴者，皆賴神氣以充塞之。若神氣有虧，則鬼神得而憑之，猶之風寒之能傷人也。故治寒者壯其陽，治熱者養其陰，治鬼者充其神而已。其或有因痰因思因驚者，則當求其本而治之。故明理之士，必事事窮其故，乃能無所惑而有據。否則執一端之見，而昧事理之實，均屬憤憤矣。其外更有觸犯鬼神之病，則祈禱可愈。至於冤譴之鬼，則有數端，有自作之孽，深仇不可解者；有祖宗貽累者；有過誤害人者，其事皆鑿鑿可徵。似儒者所不道，然見於經史，如公子彭生、伯有之類甚多，目睹者亦不少，此則非藥石祈禱所能免矣。

腎虛非陰症論

今之醫者，以其人房勞之後，或遺精之後，感冒覺寒而發熱者，謂之陰症。病者遇此，亦自謂之陰症。不問其現症何如，總用參、朮、附、桂、乾薑、地黃等溫熱峻補之藥。此可稱絕倒者也。夫所謂陰症者，寒邪中於三陰經也。房後感風，豈風寒心中腎經？即使中之，亦不過散少陰之風寒，如傷寒論中少陰發熱，仍用麻黃、細辛發表而已。豈有用辛熱溫補之法耶？若用溫補，則補其風寒於腎中矣。況陰虛之人而感風寒，亦必由太陽入，仍屬陽邪，其熱必甚，兼以燥悶煩渴。尤宜清熱散邪，豈可反用熱藥？若果直中三陰，則斷無壯熱之理。必有惡寒、倦臥、厥冷、喜熱等症，方可用溫散，然亦終無用滋補之法。即如傷寒差後房事不慎，又發寒熱，謂之女勞復。此乃久虛之人，復患大症。依今人之見，尤宜峻補者也。而古人治之，用竹皮一升煎湯服，然則無病而房後感風，更不宜用熱補矣。故凡治病之法，總視目前之現證現脈。如果六脈沉遲，表裏皆畏寒，的係三陰之寒證。即使其本領強壯

，又絕慾十年，亦從陰治。若使所現脈證的係陽邪，發熱煩渴，並無三陰之症。即使其人本體虛弱，又復房勞過度，亦從陽治。如傷寒論中陽明大熱之證，宜用葛根、白虎等方者，瞬息之間，轉入三陰，即改用溫補；若陰症轉陽症，亦即用涼散，此一定之法也。近世惟喻嘉言先生能知此義，有寓意草中黃長人之傷寒案可見。餘人皆不知之，其殺人可勝道哉。

吐血不死咳嗽必死論

今之醫者，謂吐血為虛勞之病，此大謬也。夫吐血有數種，大概咳者成勞，不咳者不成勞。間有吐時偶咳者，當其吐血之時，狼狽頗甚，吐止即痊，皆不成勞何也？其吐血一止，則週身無病，飲食如故，而精神生矣。即使亡血之後，或陰虛內熱，或筋骨疼痛，皆可服藥而痊。若咳嗽則血止而病仍在，日嗽夜嗽，痰壅氣升，多則三年，少則一年而死矣。蓋咳嗽不止，則腎中之元氣震蕩不寧，肺為腎之母，母病則子亦病故也。又肺為五臟之華蓋，經云：穀氣入胃以傳於肺，五臟六腑皆以受氣，其清者為榮，濁者為衛。是則臟腑皆取精於肺，肺病則不能輸精於臟腑，一年而臟腑皆枯，三年而臟腑竭矣。故咳嗽為真勞不治之疾也。然亦有咳嗽而不死者，其嗽亦有時稍緩，其飲食起居不甚變，又其人善於調攝。延經三年之後，起居如舊，間或一發，靜養即愈，此乃百中難得一者也。更有不咳之人，血症屢發，肝竭肺傷，亦變咳嗽，久而亦死。此則不善調攝，以輕變重也。執此以決血症之死生，百不一失矣。

胎產論

婦科之最重者二端，墮胎與難產耳。世之治墮胎者，往往純用滋補；治難產者，往往專於攻下，二者皆非也。蓋半產之故非一端，由於虛滑者，十之一二；由於內熱者，十之八九。蓋胎惟賴血以養，故得胎之後，經事不行者，因衝任之血皆為胎所吸，無餘血下行也。苟血或不足，則胎枯竭而下墮矣。其血所以不足之故，皆由內熱火盛，陽旺而陰虧也。故古人養胎之方，專以黃芩為主。又血之生，必由於脾胃。經云：榮衛之道，納穀為寶。故又以白朮佐之。乃世之人專以參耆補氣，熟地滯胃。氣旺則火盛，胃濕則不運，生化之源衰，而血益少矣。至於產育之事，乃天地化育之常，本無危險之理，險者千不得一。世之遭厄難者，乃人事之未工也。其法在乎產婦，不可令早用力。蓋胎必轉而後下，早用力則胎先下墜，斷難舒轉，於是橫生倒產之害生。又用力則胞漿驟下，胎已枯澀，何由能產？此病不但產子之家不知，即收生穩婦亦有不知者。至於用藥之法，則交骨不開，胎元不轉，種種諸症，各有專方。其外或宜潤，或宜降，或宜溫，或宜涼，亦當隨症施治。其大端以養血

為主，蓋血足則諸症自退也。至於易產強健之產婦，最多卒死。蓋大脫血之後，衝任空虛，經脈嬌脆。健婦不以為意，輕舉妄動，用力稍重，衝脈斷裂，氣冒血崩，死在頃刻。尤忌舉手上頭，如是死者，吾見極多。不知者以為奇異，實理之常，生產之家不可不知也。

病有不必要服藥論

天下之病，竟有不宜服藥者，如黃疸之類是也。黃疸之症，仲景原有煎方，然輕者用之俱效，而重者俱不效何也？蓋疸之重者，其脅中有囊以裹黃水，其囊並無出路。藥祇在囊外，不入囊中，所服之藥，非補邪即傷正，故反有害。若輕病則囊尚未成，服藥有效。至囊成之後，則百無一效。必須用輕透之方，或破其囊，或消其水。另有秘方傳授，非泛然煎丸之所能治也。痰飲之病亦有囊，常藥亦不能癒。外此如吐血久痞等疾，得藥之益者甚少，受藥誤者甚多。如無至穩必效之方，不過以身試藥，則寧以不服藥為中醫矣。

方藥離合論

方之與藥，似合而實離也。得天地之氣，成一物之性，各有功能，可以變易血氣以除疾病，此藥之力也。然草木之性，與人殊體，入人腸胃何以能如人之所欲，以致其效？聖人為之製方以調劑之，或用以專攻，或用以兼治，或相輔者，或相反者，或相用者，或相制者。故方之既成，能使藥各全其性，亦能使藥各失其性。操縱之法，有大權焉，此方之妙也。若夫按病用藥，藥雖切中，而立方無法，謂之有藥無方，或守一方以治病。方雖良善，而其藥有一二味與病不相關者，謂之有方無藥。譬之作書之法，用筆已工，而配合顛倒，與夫字形俱備，而點畫不成者，皆不得謂之能書。故善醫者，分觀之，而無藥弗切於病情；合觀之，而無方不本於古法。然後用而弗效，則病之故也，非醫之罪也。而不然者，即偶或取效，隱害必多，則亦同於殺人而已矣。至於方之大小奇偶之法，則《內經》詳言之，茲不復贅云

古方加減論

古人製方之義，微妙精詳，不可思議。蓋其審察病情，辨別經絡，參考藥性，斟酌輕重，其於所治之病，不爽毫髮。故不必有奇品異術，而沈痼艱險之疾，投之輒有神效，此漢以前之方也。但生民之疾病不可勝窮，若必每病製一方，是曷有盡期乎

？故古人即有加減之法。其病大端相同，而所現之症或不同，則不必更立一方。即於是方之內，因其現症之異而為之加減。如傷寒論中治太陽病用桂枝湯，若見項背強者，則用桂枝加葛根湯；喘者則用桂枝加厚朴杏子湯；下後脈促胸滿者，桂枝去芍湯；更惡寒者，去芍加附子湯，此猶以藥為加減者也。若桂枝麻黃各半湯，則以兩方為加減矣。若發奔豚者，用桂枝為加桂枝湯，則又以藥之輕重為加減矣。然一二味加減，雖不易本方之名，而必明著其加減之藥。若桂枝湯倍用芍藥而加飴糖，則又不名桂枝加飴糖湯，而為建中湯。其藥雖同，而義已別，則立名亦異。古法之嚴如此，後之醫者不識此義，而又欲託名用古，取古方中一二味，則即以某方目之。如用柴胡，則即曰小柴胡湯，不知小柴胡之力，全在人參也；用豬苓、澤瀉，即曰五苓散，不知五苓之妙，專在桂枝也。去其要藥，雜以他藥，而仍以某方目之。用而不效，不知自咎，或則歸咎於病，或則歸咎於藥，以為古方不可治今病。嗟乎！即使果識其病而用古方，支離零亂，豈有效乎？遂相戒以為古方難用，不知全失古方之精義，故與病毫無益而反有害也。然則當何如？曰：能識病情與古方合者，則全用之；有別症，則據古法加減之；如不盡合，則依古方之法，將古方所用之藥而去取損益之。必使無一藥之不對症，自然不倍於古人之法，而所投必有神效矣。

方劑古今論

後世之方，已不知幾億萬矣，此皆不足以名方者。昔者聖人之製方也，推藥理之本原，識藥性之專能，察氣味之從逆，審臟腑之好惡，合君臣之配耦，而又探索病源，推求經絡。其思遠，其義精，味不過三四，而其用變化不窮。聖人之智，真與天地同體，非人之心思所能及也。上古至今，千聖相傳，無敢失墜。至張仲景先生，復申明用法，設為問難，註明主治之症。其傷寒論金匱要略，集千聖之大成，以承先而啟後，萬世不能出其範圍，此謂之古方與《內經》並垂不朽。其前後名家，如倉公、扁鵲、華陀、孫思邈諸人，各有師承，而淵源又與仲景微別，然猶自成一家，但不能與靈素本草一線相傳為宗枝正脈耳。既而積習相仍，每著一書，必自撰方千百。唐時諸公，用藥雖博，已乏化機。至於宋人，並不知藥，其方亦板實膚淺。元時號稱極盛，各立門庭，徒聘私見，迨乎有明，蹈襲元人續餘而已。今之醫者，動云古方，不知古方之稱，其指不一，謂上古之方，則自仲景先生流傳以外無幾也。如謂宋元所製之方，則其可傳可法者絕少，不合法而荒謬者甚多，豈可奉為章典？若謂自明人以前，皆稱古方，則其方不下數百萬。夫常用之藥不過數百品，而為方數百萬，隨拈幾味皆已成方，何必定云某方也。嗟嗟，古之方何其嚴，今之方何其易，其間亦有奇巧之法，用藥之妙，未必不能補古人之所未及，可備參考者。然其大經大法，則萬不能及，其中更有違經背法之方，反足貽害。安得有學之士，為之擇而存之，集其大成，刪其無當，實千古之盛舉，余蓋有志而未遑矣。

單方論

單方者，藥不過一二味，治不過一二症，而其效則甚捷。用而不中，亦能害人，即世所謂海上方者是也。其原起於本草，蓋古之聖人，辨藥物之性，則必著其功用，如逐風、逐寒、解毒、定痛之類。凡人所患之症止一二端，則以一藥治之，藥專則力厚，自有奇效。若病兼數症，則必合數藥而成方。至後世藥品日增，單方日多，有效有不效矣。若夫內外之感，其中自有傳變之道，虛實之殊，久暫之別，深淺之分，及夫人性各殊，天時各異，此非守經達權者不能治。若皆以單方治之，則藥性專而無製，偏而不醇，有利必有害。故醫者不可以此嘗試，此經方之所以為貴也，然參考以廣識見，且為急救之備，或為專攻之法，是亦不可不知者也。

禁方論

天地有好生之德，聖人大公之心，立方以治病，使天下共知之，豈非天地聖人之至願哉？然而方之有禁則何也？其故有二：一則懼天下之輕視夫道也。夫經方之治病，視其人學問之高下以為效驗，故或用之而愈，或用之而反害，變化無定，此大公之法也。若禁方者，義有所不解，機有所莫測。其傳也，往往出於奇人隱士仙佛鬼神，其遇之也甚難，則愛護之必至。若輕以授人，必生輕易之心，所以方家往往愛惜，此乃人之情也。一則恐發天地之機也。禁方之藥，其製法必奇，其配合必巧，窮陰陽之柄，窺造化之機。其修合必虔誠敬慎，少犯禁忌，則藥無驗。若輕以示人，則氣洩而用不神，此又陰陽之理也。靈樞禁服篇，黃帝謂雷公曰：此先師之所禁，割臂插血之盟也。故黃帝有蘭臺之藏，長桑君有無泄之戒，古聖皆然。若夫詭詐之人，專欲圖利，託名禁方，欺世惑眾。更有修煉熱藥，長慾道淫，名為養生，實速其死，此乃江河惡習，聖人之所必誅也。又有古之禁方，傳之已廣，載入醫書中與經方並垂，有識者，自能擇之也。

古成方劑大小論

今人以古人氣體充實，故方劑分兩甚重，此無稽之說也。自三代至漢晉，升斗權衡，雖有異同，以今較之，不過十分之二（余親見漢時有六升銅量容，今之一升二合）。如桂枝湯傷寒大劑也，桂枝為藥各三兩，甘草二兩，共八兩為一劑，在今只一兩八錢，又分三服，則一服不過五錢三分零。他方有藥品多者，亦不過倍之而已。況古時之藥，醫者自備，俱用鮮者，分兩以鮮者為準，乾則折算。如半夏、麥冬之類，皆生大而乾小，至附子野生者甚小，後人種之乃肥大，皆有確證。今然每方必十餘味，每味三、四錢，則一劑重二三兩矣。更有熟地用至四兩一劑者，尤屬可怪。

，古丸藥如烏梅丸，每服如桐子大十丸，今秤不過二三分，今則用三四錢至七八錢矣。古末藥用方寸匕，不過今之六七分，今服三四錢矣。古人用藥分兩，未嘗從重。（周禮遺人凡萬民之食食者，人四〔鬲甫〕。六斗四升曰〔鬲甫〕，四〔鬲甫〕共二石五斗六升，為人一月之食，則每日食八升有餘矣。蓋一升只二合也。）二十年來，時醫誤閱古方，增重分兩，此風日熾，即使對病，元氣不勝藥力，亦必有害，況更與病相反，害不尤速乎？既不考古，又無師授，無怪乎其動成笑柄也。

藥誤不即死論

古人治法，無一方不對病，無一藥不對症，如是而病猶不愈，此乃病本不可愈，非醫之咎也。後世醫失其傳，病之名亦不能知，宜其胸中毫無所主也。凡一病有一病之名，如中風總名也，其類有偏枯、痿痺、風痲、歷節之殊。而諸症之中，又各有數症，各有定名，各有主方。又如水腫總名也，其類有皮水、正水、石水、風水之殊，而諸症又各有數症，各有定名，各有主方。凡病盡然，醫者必能實指其何名，遵古人所主何方，加減何藥，自有法度可循。乃不論何病，總以陰虛陽虛等籠統之談概之，而試以籠統不切之藥。然亦竟有愈者，或其病本輕，適欲自愈，或偶有一二對症之藥，亦奏小效，皆屬誤治，其得免於殺人之名者何也？蓋殺人之藥，必大毒如砒鴆之類，或大熱大寒峻厲之品，又適與病相反，服後立見其危。若尋常之品，不過不能愈病，或反增他病耳，不即死也，久即死也。久而病氣自退，正氣自復，無不愈者。間有遷延日久，或隱受其害而死。更或屢換庸醫，遍試諸藥，久而病氣益深，元氣竭亦死。又有初因誤治，變成他病，輾轉而死。又有始服有小效，久服太過，反增他病而死。蓋日日診視，小效則以為可愈，小劇又以為難治，並無誤治之形，確有誤治之實。病家以為病久不痊，自然不起，非醫之咎，因其不即死而不之罪，其實則真殺之而不覺也。若夫誤投峻厲相反之藥，服後顯然為害，此其殺人，人人能知之矣。惟誤服參附峻補之藥而即死者，則病家之所甘心，必不歸咎於醫，故醫者雖自知其誤，必不以此為戒，而易其術也。

藥石性同用異論

一藥有一藥之性情功效，其藥能治某病，古方中用之以治某病，此顯而易見者。然一藥不止一方用之，他方用之亦效何也？蓋藥之功用不止一端，在此方則取其此長，在彼方則取其彼長，真知其功效之實，自能曲中病情而得其力。迨至後世，一藥所治之病愈多，而亦效者，蓋古人尚未盡知之，後人屢試而後知。所以歷代本草所註藥性，較之神農本經所註功用增益數倍，蓋以此也。但其中有當有不當，不若神農本草字字精切耳。又同一熱藥，而附子之熱與乾薑之熱，迥乎不同；同一寒藥，

而石膏之寒與黃連之寒，迥乎不同。一或誤用，禍害立至。蓋古人用藥之法，並不專取其寒熱溫涼補瀉之性也。或取其氣，或取其味，或取其色，或取其形，或取其所生之方，或取其嗜好之偏。其要似與病情之寒熱溫涼補瀉若不相關，而投之反有神效，古方中如此者，不可枚舉。學者必將神農本草，字字求其精義之所在，而參以仲景諸方，則聖人之精理，自能洞曉。而已之立方，亦必有奇思妙想，深入病機，而天下無難治之症也。

劫劑論

世有奸醫，利人之財，取效於一時，不顧人之生死者，謂之劫劑。劫劑者，以重藥奪截邪氣也。夫邪之中人，不能使之一時即出，必漸消漸托而後盡焉。今欲一日見效，勢必用猛厲之藥，與邪相爭，或用峻補之藥，遏抑邪氣；藥猛厲則邪氣暫伏，而正亦傷，藥峻補則正氣驟發，而邪內陷。一時似乎有效，及至藥力盡而邪復來，元氣已大壞矣。如病者身熱甚，不散其熱，而以沉寒之藥遏之；腹痛甚不求其因，而以香燥禦之；瀉痢甚不去其積，而以收斂之藥塞之之類，此峻厲之法也。若邪盛而投以大劑參附，一時陽氣大旺，病氣必潛藏，自然神氣略定。越一二日，元氣與邪氣相併，反助邪而肆其毒，為禍尤烈，此峻補之法也。此等害人之術，奸醫以此欺人而騙財者，十之五，庸醫不知而效尤以害人者，亦十之五，為醫者可不自省，病家亦不可不察也。

製藥論

製藥之法，古方甚少，而最詳於宋之雷〔學支〕，今世所傳雷公炮炙論是也。後世製藥之法，日多一日，內中亦有至無理者，固不可從，若其微妙之處，實有精義存焉。凡物氣厚力大者，無有不偏，偏則有利必有害，欲取其利而去其害，則用法以製之，則藥性之偏者醇矣。其製之義，又各不同，或以相反為製，或以相資為製，或以相惡為製，或以相畏為製，或以相喜為製。而製法又復不同，或製其形，或製其性，或製其味，或製其質，此皆巧於用藥之法也。古方製藥無多，其立方之法，配合氣性。如桂枝湯中用白芍，亦即有相製之理，故不必每藥製之也。若後世好奇眩異之人，必求貴重怪僻之物，其製法大費工本，以神其說，此乃好奇尚異之人，造作以欺誑富貴人之法，不足憑也。惟平和而有理者，為可從耳。

人參論

天下之害人者，殺其身未必破其家，破其家未必殺其身。先破人之家而後殺其身者，人參也。夫人參用之而當，實能補養元氣，拯救危險，然不可謂天下之死人皆能生之也。其為物氣盛而力厚，不論風寒暑濕痰火鬱結，皆能補塞。故病人如果邪去正衰，用之固宜，或邪微而正亦憊，或邪深而正氣怯弱，不能逐之於外，則於除邪藥中投之，以為驅邪之助。然又必審其輕重而後用之，自然有扶危定傾之功。乃不察其有邪無邪，是虛是實，又佐以純補溫熱之品，將邪氣盡行補住，輕者邪氣永不復出，重者即死矣。夫醫者之所以遇疾即用，而病家服之死而無悔者何也？蓋愚人之心，皆以價貴為良藥，價賤為劣藥，而常人之情，無不好補而惡攻。故服參而死，即使明知其誤，然以為服人參而死，則醫者之力已竭，而人子之心已盡，此命數使然，可以無恨矣。若服攻削之藥而死，即使用死，即使用藥不誤，病實難治，而醫者之罪已不可勝誅矣。故人參者，乃醫家邀功避罪之聖藥也。病家如此，醫家如此，而害人無窮矣。更有駭者，或以用人參為冠冕，或以用人參為有力量。又因其貴重，深信以為必能挽回造化，故毅然用之。孰知人參一用，凡病之有邪者即死。其不死者，亦終身不得愈乎。其破家之故何也？蓋向日之人參，不過一二換，多者三四換，今則其價十倍，其所服又非一錢二錢而止。小康之家，服二三兩而家已蕩然矣。夫人情於死生之際，何求不得，寧恤破家乎！醫者全不一念，輕將人參立方，用而不遵，在父為不慈，在子為不孝，在夫婦昆弟為忍心害理。并有親戚雙友，責罰痛罵，即使明知無益，姑以此塞責。又有孝子慈父，倖其或生，竭力以謀之。遂使貧窶之家，病或稍愈，一家終身凍餒。若仍不救，棺殮俱無，賣妻鬻子，全家覆敗。醫者誤治，殺人可恕，而逞己之意，日日害人破家，其惡甚於盜賊，可不慎哉！吾願天下之人，斷不可以人參為起死回生之藥，而必服之。醫者必審其病，實係純虛，非參不治，服必萬全，然後用之。又必量其家業尚可以支持，不至用參之後，死生無靠。然後節省用之，一以惜物力，一以全人之命，一以保人之家。如此存心，自然天降之福。若如近日之醫，殺命破家於人不知之地，恐天之降禍，亦在人不知之地也，可不慎哉。

用藥如用兵論

聖人之所以全民生也，五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。而毒藥則以之攻邪，故雖甘草、人參，誤用致害，皆毒藥之類也。古人好服食者，必生奇疾，猶之好戰勝者，必有奇殃。是故兵之設也以除暴，不得已而後興；藥之設也以攻疾，亦不得已而後用，其道同也。故病之為患也，小則耗精，大則傷命，隱然一敵國也。以草木偏性，攻臟腑之偏勝，必能知彼知己。多方以制之，而後無喪身殞命之憂。是故傳經之邪，而先奪其未至，則所以斷敵之要道也；橫暴之疾，而急保其未病，則所以守我之巖疆也。挾宿食而病者，先除其食，則敵之資糧已焚；合舊疾而發者，必防其併，則敵之內應既絕。辨經絡而無泛用之藥，此之謂向導之師；因寒熱而有反用之方，此之謂行間之術。一病而分治之，則用寡可以勝眾，使前後不相救

，而勢自衰；數病而合治之，則併力搗其中堅，使離散無所統，而眾悉潰。病方進，則不治其太甚，固守元氣，所以老其師；病方衰，則必窮其所之，更益精銳，所以搗其穴。若夫虛邪之體，攻不可過，本和平之藥，而以峻藥補之，衰敝之日不可窮民力也；實邪之傷，攻不可緩，用峻厲之藥，而以常藥和之，富強之國可以振威武也。然而選材必當，器械必良，剋期不愆，布陣有方，此又不可更僕數也。孫武子十三篇，治病之法盡之矣。

執方治病論

古人用藥立方，先陳列病症，然後云某方主之。若其症少有出入，則有加減之法，附於方後。可知方中之藥，必與所現之症纖悉皆合，無一味虛設，乃用此方，毫無通融也。又有一病而云某方亦主之者，其方或稍有異同，或竟不同，可知一病并不止一方所能治。今乃病名稍似，而其中之現症全然不同，乃亦以此方施治，則其藥皆不對症矣。并有病名雖一，病形相反，亦用此方，則其中盡屬相反之藥矣。總之欲用古方，必先審病者所患之症，悉與古方前所陳列之症皆合，更檢方中所用之藥，無一不與所現之症相合，然後施用，否則必須加減。無可加減，則另擇一方。斷不可道聽塗說，聞某方可以治某病，不論其因之異同，症之出入，而冒昧施治。雖所用悉本於古方，而害益大矣。

湯藥不足盡病論

《內經》治病之法，針灸為本，而佐之以砭石、熨浴、導引、按摩、酒醴等法，病各有宜，缺一不可。蓋服藥之功，入腸胃而氣四達，未嘗不能行於臟腑經絡。若邪在筋骨肌肉之中，則病屬有形，藥之氣味，不能奏功也。故必用針灸等法，即從病之所在，調其血氣，逐其風寒，為實而可據也。況即以服藥論，止用湯劑，亦不能盡病。蓋湯者盪也，其行速，其質輕，其力易過而不留，惟病在榮衛腸胃者，其效更速。其餘諸病，有宜丸宜散宜膏者，必醫者豫備，以待一時急用。視其病之所在，而委曲施治，則病無遁形。故天下無難治之症，而所投輒有神效，扁鵲、倉公所謂禁方者是也。若今之醫者，祇以一煎方為治，惟病後調理，則用滋補丸散，盡廢聖人之良法，即使用藥不誤，而與病不相入，則終難取效。故扁鵲云：人之所患患病多，醫之所患患道少。近日病變愈多，而醫家之道愈少，此痼疾之所以日多也。

本草古今論

本草之始，昉於神農，藥止三百六十品。此乃開天之聖人，與天地為一體，實能探造化之精，窮萬物之理，字字精確，非若後人推測而知之者。故對症施治，其應若響。仲景諸方之藥，悉本此書，藥品不多，而神明變化，已無病不治矣。迨其後藥味日多，至陶弘景倍之，而為七百二十品。後世日增一日，凡華夷之奇草逸品，試而有效，醫家皆取而用之。代有成書，至明李時珍，增益唐慎微證類本草為綱目，考其異同，辦其真偽，原其生產，集諸家之說，而本草更大備，此藥味由少而多之故也。至其功用，則亦後人試驗而知之。故其所治之病益廣，然皆不若神農本草之純正直確。故宋人有云：用神農之品無不效，而弘景所增已不甚效。若後世所增之藥，則尤有不足憑者，至其詮釋，大半皆視古方用此藥醫某病則增註之。或古方治某病，藥不止一品，而誤以方中此藥為專治此病者有之，更有以己意推測而知者。又或偶愈一病，實非此藥之功，而強著其效者，種種難信。至張潔古、李東垣輩，以某藥專派入某經，則更穿鑿矣。其詳在治病不必分經絡臟腑篇。故論本草，必以神農為本，而他說則必審擇而從之，必驗之於病而後信。又必考古人方中所曾用者，乃可採取，餘則止可於單方外治之法用之。又有後世所增之奇藥，或出於深山窮谷，或出於殊方異域，前世所未嘗有者，後人用之，往往有奇效。此乃偏方異氣之所鍾，造物之機，久而愈洩，能治古方所不能治之奇病。博物君子，亦宜識之，以廣見聞，此又在本草之外者矣。

藥性變遷論

古方所用之藥，當時效驗顯著，而本草載其功用鑿鑿者，今依方施用，竟有應有不應，其故何哉？蓋有數端焉。一則地氣之殊也。當時初用之始，必有所產之地，此乃其本生之土，故氣厚而力全。以後傳種他方，則地氣移而力薄矣。一則種類之異也。凡物之種類不一，古人所採，必至貴之種，後世相傳，必擇其易於繁衍者而種之，未必皆種之至貴者。物雖非偽，而種則殊矣。一則天生與人力之異也。當時所採，皆生於山谷之中，元氣未洩，故得氣獨厚。今皆人功種植，既非山谷之真氣，又加灌溉之功，則性平淡而薄劣矣。一則名實之訛也。當時藥不市賣，皆醫者自取而備之。迨其後有不常用之品，後人欲得而用之，尋求採訪，或誤以他物充之，或以別種代之，又肆中未備，以近似者欺人取利，此藥遂失其真矣。其變遷之因，實非一端。藥性既殊，即審病極真，處方極當，奈其藥非當時之藥，則效亦不可必矣。今之醫者，惟知定方，其藥則惟病家取之肆中，所以真假莫辨，雖有神醫，不能以假藥治真病也。

藥性專長論

藥之治病，有可解者，有不可解者。如性熱能治寒，性燥能治濕，芳香則通氣，滋潤則生津，此可解者也。如同一發散也，而桂枝則散太陽之邪，柴胡則散少陽之邪。同一滋陰也，而麥冬則滋肺之陰，生地則滋腎之陰。同一解毒也，而雄黃則解蛇蟲之毒，甘草則解飲食之毒。已有不可盡解者，至如鱉甲之消痞塊，史君子之殺蛔蟲，赤小豆之消膚腫，薏仁生服不眠、熟服多睡，白鶴花之不腐肉而腐骨，則尤不可解者，此乃藥性之專長，即所謂單方秘方也。然人止知不可解者之為專長，而不知常用藥之中，亦各有專長之功。後人或不知之而不能用，或日用而忽焉，皆不能盡收藥之功效者也。故醫者當廣集奇方，深明藥理，然後奇症當前，皆有治法，變化不窮。當年神農著本草之時，既不能睹形而即識其性，又不可每藥歷試而知，竟能深識其功能，而所投必效，豈非與造化相為默契，而非後人思慮之所能及者乎

煎藥法論

煎藥之法，最宜深講，藥之效不效，全在乎此。夫烹飪禽魚羊豕，失其調度，尚能損人，況藥專以之治病而可不講乎？其法載於古方之末者，種種各殊。如麻黃湯先煮麻黃去沫，然後加餘藥同煎，此主藥當先煎之法也。而桂枝湯又不必先煎桂枝，服藥後須啜熱粥以助藥力，又一法也。如茯苓桂枝甘草大棗湯，則以甘瀾水先煎茯苓。如五苓散則以白飲和服，服後又當多飲煖水。小建中湯則先煎五味去渣，而後納飴糖。大柴胡湯則煎減半，去渣再煎。柴胡加龍骨牡蠣湯，則煎藥成而後納大黃。其煎之多寡，或煎水減半，或十分煎去二三分，或止煎一二十沸，煎藥之法，不可勝數，皆各有意義。大都發散之藥及芳香之藥，不宜多煎，取其生而疏溫。補益滋膩之藥宜多煎，取其熟而停蓄，此其總訣也。故方藥雖中病，而煎法失度，其藥必無效。蓋病家之常服藥者，或尚能依法為之。其粗魯貧苦之家，安能如法制度？所以病難愈也。若今之醫者，亦不能知之矣，況病家乎？

服藥法論

病之愈不愈，不但方必中病，方雖中病而服之不得其法，則非特無功而反有害，此不可不知也。如發散之劑，欲驅風寒出之於外，必熱服而煖覆其體，令藥氣行於榮衛，熱氣周遍，挾風寒而從汗解。若半溫而飲之，仍當風坐立，或僅寂然安臥，則藥留腸胃不能得汗，風寒無暗消之理，而榮氣反為風藥所傷矣。通利之藥，欲其化積滯而達之於下也。必空腹頓服，使藥性鼓動，推其垢濁從大便解。若與飲食雜投，則新舊混雜，而藥氣與食物相亂，則氣性不專，而食積愈頑矣。故傷寒論等書服藥之法，宜熱、宜溫、宜涼、宜冷、宜緩、宜急、宜多、宜少、宜早、宜晚、宜飽、宜飢。更有宜湯不宜散，宜散不宜丸，宜膏不宜圓。其輕重大小上下表裏，治法

各有當，此皆一定之至理。深思其義，必有得於心也。

醫必備藥論

古之醫者，所用之藥皆自備之。《內經》云：司氣備物，則無遺主矣。當時韓康賣藥，非賣藥也，即治病也。韓文公進學解云：牛溲馬渤，敗鼓之皮，俱收並蓄，待巾無遺，醫師之良也。今北方人稱醫者為賣藥先生，則醫者之自備藥可知，自宋以後。漸有寫方不備藥之醫，其藥皆取之肆中，今則舉世皆然。夫賣藥者不知醫，猶之可也。乃行醫者竟不知藥，則藥之是非真偽，全然不問，醫者與藥不相謀，方即不誤，而藥之誤多矣。又古聖人之治病，惟感冒對疾，則以煎劑為主，餘者皆用丸散為多。其丸散有非一時所能合者，倘有急迫之疾，必須丸散，俟丸散合就而人亡死矣。又有一病止須一丸而愈，合藥不可止合一丸。若使病家為一人而合一料，則一丸之外皆為無用。惟醫家合之，留待當用者用之，不終棄也。又有不常用不易得之藥，儲之數年，難遇一用。藥肆之中，因無人問，則亦不備，惟醫者自蓄之，乃可待不時之需耳。至於外科所用之煎方，不過通散榮衛耳。若護心托毒，全賴各種丸散之力。其藥皆貴重難得及鍛煉之物，修合非一二日之功，而所費又大，亦不得為一人止合一二丸。若外治之圍藥、塗藥、昇藥、降藥，護肌腐肉，止血行瘀，定痛煞痒，提膿呼毒，生肉生皮，續筋連骨。又有熏蒸、烙灸、吊洗、點〔水楊〕（此字左為水部旁，右為“楊”字去木部旁）等藥，種種各異。更復每症不同，皆非一時所能備，尤必須平時豫合。乃今之醫者，既不知其方，亦不講其法，又無資本以蓄藥料。偶遇一大症，內科則一煎方之外，更無別方，外科則膏藥之外，更無餘藥。即有之，亦惟取極賤極易得之一二味，以為應酬之具。則安能使極危極險極奇極惡之症，令起死回生乎？故藥者醫家不可不全備者也。

乩方論

世有書符請仙而求方者。其所書之方，固有極淺極陋極不典，而不能治病且誤人者。亦有極高極古極奇極穩以之治病而神效者，其仙或託名呂純陽，或託名張仲景，其方亦宛然純陽、仲景之遺法，此其事甚奇，然亦有理焉。夫乩者機也，人心之感召，無所不通，既誠心於求治，則必有能治病之鬼神應之。雖非真純陽、仲景，必先世之明於醫理不遇於時而死者。其精靈一時不散，遊行於天地之間，因感而至，以顯其能。而其人病適當愈，則獲遇之，此亦有其理也。其方未必盡效，然皆必有意義，反不若世之時醫用相反不若世之時醫用相反之藥以害人。惟決死生之處，不肯鑿鑿言之，此則天機不輕洩之故也。至於不通不典之方，則必持乩之術不工，或病家之心不誠，非真乩方也。

熱藥誤人最烈論

凡藥之誤人，雖不中病，非與病相反者，不能殺人；即與病相反，藥性平和者，不能殺人；與病相反，性又不平和，而用藥甚輕，不能殺人；性既相反，藥劑又重，其方中有幾味中病者，或有幾味能解此藥性者，亦不能殺人；兼此數害，或其人病甚輕，或其人精力壯盛，亦不能殺人。蓋誤藥殺人，如此之難也。所以世之醫者，大半皆誤，亦不見其日殺數人也。即使殺之，乃輾轉因循以至於死，死者不覺也。其有幸而不死，或漸自愈者，反指所誤用之藥以為此方之功效，又轉以之誤治他人矣。所以終身誤人而不自知其咎也。惟大熱大燥之藥，則殺人為最烈。蓋熱性之藥，往往有毒，又陽性急暴，一入臟腑，則血湧氣升。若其人之陰氣本虛，或當天時酷暑，或其人傷暑傷熱。一投熱劑，兩火相爭，目赤便閉，舌燥齒乾，口渴心煩，肌裂神躁，種種惡候，一時俱發。醫者及病家俱不察，或云更宜引火歸元，或云此是陰症，當加重其熱藥，而佐以大補之品。其人七竅皆血，呼號宛轉，狀如服毒而死，病家全不以為咎，醫者亦洋洋自得，以為病勢當然。總之，愚人喜服補熱，雖死不悔，我目中所見不一，垂涕泣而道之，而醫者與病家無一能聽從者，豈非所謂命哉？夫大寒之藥亦能殺人，其勢必緩，猶為可救，不若大熱之藥斷斷不可救也。至於極輕淡之藥，誤用亦能殺人，此乃其人之本領甚薄，或勢已危殆，故小誤即能生變，此又不可全歸咎於醫殺之也。

卷下

薄貼論

今所用之膏藥，古人謂之薄貼，用大端有二：一以治表，一以治裏。治表者，如呼膿去腐，止痛生肌，并撫風護肉之類，其膏宜輕薄而日換，此理人所易知。治裏者，或驅風寒，或和氣血，或消痰痞，或壯筋骨，其方甚多，藥亦隨病加減，其膏宜重厚而久貼，此理人所難知，何也？蓋人之疾病，由外以入內，其流行於經絡臟腑者，必服藥乃能驅之。若其病既有定所，在於皮膚筋骨之間，可按而得者，用膏貼之，閉塞其氣，使藥性從毛孔而入。其腠理通經貫絡，或提而出之，或攻而散之，較之服藥尤有力，此至妙之法也。故凡病之氣聚血結而有形者，薄貼之法為良。但製膏之法，取藥必真，必志必誠，火候必到，方能有效。否則不能奏功，至於敷熨吊〔水榻〕，種種雜法，義亦相同，在善醫者通變之而已。註：〔水榻〕，左邊為三點“水”字旁，右邊為“榻”字去“木”旁。

貌似古方欺人論

古聖人之立方，不過四五味而止。其審藥性，至精至當，其察病情，至真至確。方中所用之藥，必準對其病，而無毫髮之差。無一味泛用之藥，且能以一藥兼治數症。故其藥味雖少，而無症不該。後世之人，果能審其人之病，與古方所治之病無少異，則全用古方治之，無不立效。其如天下之風氣各殊，人之氣稟各異，則不得不依古人所製主病之方，略為增減，則藥味增矣。又或病同而症甚雜，未免欲兼顧，則隨症增一二味，而藥又增矣。故後世之方，藥味增多，非其好為雜亂也。乃學不如古人，不能以一藥該數症，故變簡而為繁耳，此猶不失周詳之意。且古方之設，原有加減之法，病症雜出，亦有多品之劑，藥味至十餘種。自唐以後之方，用藥漸多，皆此義也。乃近世之醫，動云效法漢方，藥止四五味。其四五味之藥，有用浮泛輕淡之品者，雖不中病，猶無大害。若趨時之輩，竟以人參、附子、乾薑、蒼朮、鹿茸、熟地等峻補辛熱之品，不論傷寒暑濕，惟此數種輪流轉換，以成一方，種種與病相反，每試必殺人，毫不自悔。既不辨病，又不審藥性，更不記方書，以為此乃漢人之法。嗚呼！今之所學漢人之方，何其害人如此之毒也？其端起於近日之時醫，好為高論以欺人。又人情樂於溫補，而富貴之家尤甚，不如是則道不行。所以人爭效尤，以致貽害不息。安有讀書考古深思體驗之君子，出而挽回，亦世道生民之大幸也。

司天運氣論

邪說之外，有欺人之學，有耳食之學。何謂欺人之學？好為高談奇論，以駭人聽聞，或勦襲前人之語，以示淵博。彼亦自知其為全然不解，但量他人亦莫之能深考也，此為欺人之學。何謂耳食之學？或竊聽他人之說，或偶閱先古之書，略記數語，自信為已得其祕，大言不慚，以此動眾，所謂道聽塗說是也。如近人所談司天運氣之類是矣。彼所謂司天運氣者，以為何氣司天，則是年民當何病。假如厥陰司天，風氣主之，則是年之病，皆當作風治。此等議論，所謂耳食也。蓋司天運氣之說，黃帝不過言天人相應之理如此，其應驗先候於脈。凡遇少陰司天，則兩手寸口不應，厥陰司天，則右寸不應，太陰司天，則左寸不應，若在泉則尺脈不應亦如之；若脈不當其位，則病相反者死，此診脈之一法也。至於病則必觀是年歲氣勝與不勝，如厥陰司天，風淫所勝，民病心痛脅滿等症。倘是年風淫雖勝，而民另生他病，則不得亦指為風淫之病也；若是年風淫不勝，則又不當從風治矣。經又云：相火之下，水氣乘之，水位之下，火氣承之。五氣之勝皆然，此乃亢則害，承乃制之理。即使果勝，亦有相剋者乘之，更與司天之氣相反矣。又云初氣終三氣，天氣主之，勝之常也；四氣盡終氣，地氣主之，復之常也。有勝則復，無勝則否。則歲半以前屬司天，歲半以後又屬在泉，其中又有勝不勝之殊，其病更無定矣。又云：厥陰司天，左少陰，右太陽。謂之左間右間，六氣皆有左右間，每間主六十日，是一歲之中復有六氣循環作主矣。其外又有南政北政之反其位，天符歲會三合之不齊，太過不及之異氣，欲辨明分晰，終年不能盡其蘊。當時聖人，不過言天地之氣運行旋轉如此耳。至於人之得病，則豈能一一與之盡合？一歲之中，不許有一人生他病乎？故《內經》治歲氣勝復，亦不分所以得病之因。總之，則病治病，如風淫於內，則治以辛涼，六氣皆有簡便易守之法。又云：治諸勝復，寒者熱之，熱者寒之，溫者清之，清者溫之。無問其數，以平為期，何等劃一。凡運氣之道，言其深者，聖人有所不能知，及施之實用，則平正通達，人人易曉。但不若今之醫者所云，何氣司天則生何病，正與《內經》圓機活法相背耳。

醫道通治道論

治身猶治天下也。天下之亂，有由乎天者，有由乎人者。由乎天者，如夏商水旱之災是也；由乎人者，如歷代季世之變是也。而人之病，有由乎先天者，有由乎後天者。由乎先天者，其人生而虛弱柔脆是也；由乎後天者，六淫之害七情之感是也。先天之病，非其人之善養與服大藥，不能免於夭折；猶之天生之亂，非大聖大賢不能平也。後天之病，乃風寒暑溼燥火之疾，所謂外患也；喜怒憂思悲驚恐之害，所謂內憂也。治外患者以攻勝，四郊不靖，而選將出師，速驅除之可也；臨辟雍而講禮樂，則敵在門矣。故邪氣未盡而輕用補者，使邪氣內入而亡。治內傷者以養勝，綱紀不正，而崇儒講道，徐化導之可也。若任刑罰而嚴誅戮，則禍益深矣。故正氣不足而輕用攻者，使其正氣消盡而亡。然而大盛之世，不無玩民，故刑罰不廢，則補中之攻也。然使以小寇而遽起戎兵，是擾民矣。故補中之攻不可過也。征誅之年

，亦修內政，故教養不弛，則攻中之補也。然以戎首而稍存姑息，則養寇矣。故攻中之補不可誤也。天下大事，以天下全力為之，則事不墮；天下小事，以一人從容處之，則事不擾。患大病以大藥制之，則病氣無餘；患小病以小方處之，則正氣不傷。然而施治有時，先後有序，大小有方，輕重有度，疏密有數，純而不雜，整而不亂，所用之藥，各得其性。則器使之道，所處之方，各得其理；則調度之法，能即小以喻大。誰謂良醫之法，不可通於良相也。

五方異治論

人稟天地之氣以生，故其氣體隨地不同。西北之人氣深而厚，凡受風寒，難於透出，宜用疏通重劑；東南之人氣浮而薄，凡遇風寒，易於疏洩，宜用疏通輕劑。又西北地寒，當用溫熱之藥；然或有邪蘊於中而內反甚熱，則用辛寒為宜。東南地溫，當用清涼之品；然或有氣隨邪散，則易於亡陽，又當用辛溫為宜。至交廣之地，則汗出無度，亡陽尤易，附桂為常用之品。若中州之卑濕，山陝之高燥，皆當隨地制宜。故入其境，必問水土風俗而細調之。不但各府各別，即一縣之中，風氣亦有迥殊者，并有所產之物，所出之泉，皆能致病。土人皆有極效之方，皆宜詳審訪察。若恃己之能，執己之見，治竟無功，反為土人所笑矣。湖州長興縣有合溪，小兒飲此水則腹中生痞。土人治法：用線掛頭，以兩頭按乳頭上剪斷，即將此線掛轉，將兩頭向背脊上一併拽齊線頭盡處，將黑點記脊上。用艾灸之，或三壯，或七壯即消。永不再發，服藥無效。

病隨國運論

天地之氣運，數百年一更易，而國家之氣運亦應之。上古無論，即以近代言。如宋之末造，中原失陷，主弱臣弛。張潔古、李東垣輩，立方皆以補中宮，健脾胃，用剛燥扶陽之藥為主，局方亦然。至於明季，主暗臣專，膏澤不下於民。故丹溪以下諸醫，皆以補陰益下為主。至我本朝，運當極隆之會，聖聖相承，大權獨攬，朝綱整肅，惠澤旁流，此陽盛於上之明徵也。又冠飾朱纓，口燔煙草，五行惟火獨旺。故其為病，皆屬盛陽上越之症。數十年前，雲間老醫知此義者，往往專以芩、連、知、柏挽回誤投溫補之人，應手奇效，此實與運氣相符。近人不知此理，非惟不能隨症施治，并執寧過溫熱，毋過寒冷之說。偏於溫熱，又多矯枉過正之論。如中暑一症，或有伏陽在內者，當用大順散、理中湯，此乃千中之一。今則不論何人，凡屬中暑，皆用理中等湯。我目睹七竅皆裂而死者，不可勝數。至於託言祖述東垣用蒼朮等燥藥者，舉國皆然。此等惡習，皆由不知天時國運之理，誤引舊說以害人也。故古人云：不知天地人者，不可以為醫。

針灸失傳論

靈素兩經，其詳論藏府經穴疾病等說。為針法言者，十之七八；為方藥言者，十之二三。上古之重針法如此，然針道難而方藥易，病者亦樂於服藥而苦於針，所以後世方藥盛行，而針法不講。今之為針者，其顯然之失有十，而精微尚不與焉。兩經所言十二經之出入起止淺深左右，交錯不齊，其穴隨經上下，亦參差無定。今人祇執同身寸依左右一直豎量，並不依經曲折，則經非經而穴非穴，此一失也。兩經治病云，某病取某穴者固多，其餘則指經而不指穴。如靈樞終始篇云：人迎一盛，瀉足少陽，補足太陰。厥病篇云：厥頭痛，或取足陽明太陰，或取手少陽足少陰；耳聾取手

水病針法論

凡刺之法，不過補瀉經絡，祛邪納氣而已，其取穴甚少。惟水病風〔病水〕膚脹，必刺五十七穴。又云：皮膚之血盡取之何也？蓋水旺必剋脾土，脾土衰則遍身皮肉皆腫，不特一經之中有水氣矣。若僅刺一經，則一經所過之地水自漸消。而他經之水不消，則四面會聚，并一經已瀉之水亦仍滿矣。故必周身腫滿之處皆刺而瀉之，然後其水不復聚耳。此五十七穴者，皆藏之陰絡水之所客也，此與大禹治洪水之法同。蓋洪水泛濫，必有江淮河濟，各引其所近之眾流以入海，必不能使天下之水祇歸一河以入海也。又出水之後，更必調其飲食。經云：方飲無食，方食無飲（使飲食異居，則水不從食，以至於脾土受濕之處也），無食他食百三十五日。此症之難愈如此。余往時治此病，輕者多愈，重者必復腫。蓋由五十七穴未能全刺，而病人亦不能守戒一百三十五日也。此等大症，少違法度，即無愈理，可不慎哉。

出奇制病論

病有經有緯，有常有變，有純有雜，有正有反，有整有亂，并有從古醫書所無之病。歷來無治法者，而其病又實可愈。既無陳法可守，是必熟尋《內經》《難經》等書，審其經絡藏府受病之處，及七情六氣相感之因。與夫內外分合氣血聚散之形，必有鑿鑿可徵者，而後立為治法。或先或後，或併或分，或上或下，或前或後，取藥極當，立方極正。而寓以巧思奇法，深入病機，不使扞格。如庖丁之解牛，雖筋骨關節之間，亦游刃有餘。然後天下之病，千緒萬端，而我之設法，亦千變萬化，全在平時於極難極險之處，參悟通澈，而後能臨事不眩。否則一遇疑難，即束手無

措，冒昧施治，動輒得咎，誤人不少矣。

治病緩急論

病有當急治者，有不當急治者。外感之邪，猛悍剽疾，內犯藏府，則元氣受傷，無以托疾於外。必乘其方起之時，邪入尚淺，與氣血不相亂，急驅而出之於外，則易而且速。若俟邪氣已深，與氣血相亂，然後施治，則元氣大傷，此當急治者也。若夫病機未定，無所歸者，急用峻攻，則邪氣益橫。如人之傷食，方在胃中，則必先用化食之藥，使其食漸消，由中焦而達下焦，變成渣穢而出，自然漸愈。若即以硝黃峻藥下之，則食尚在上焦，即使隨藥而下，乃皆未化之物。腸胃中脂膜與之全下，而人已大疲，病必生變，此不當急治者也。以此類推，餘病可知。至於虛人與老少之疾，尤宜分別調護，使其元氣漸轉，則正復而邪退。醫者不明此理，而求速效，則補其所不當補，攻其所不當攻。所服之藥不驗，又轉求他法，無非誅伐無過。至當愈之時，其人已為藥所傷，而不能與天地之生氣相應矣。故雖有良藥，用之非時，反能致害，緩急之理，可不講哉。

治病分合論

一病而當分治者，如痢疾、腹痛、脹滿。則或先治脹滿，或先治腹痛，即脹滿之中亦不同。或因食，或因氣，或先治食，或先治氣。腹痛之中亦不同，或因積，或因寒，或先去積，或先散寒。種種不同，皆當視其輕重而審察之。以此類推，則分治之法可知矣。有當合治者，如寒熱、腹痛、頭疼、泄瀉、厥冒、胸滿，內外上下無一不病，則當求其因何而起，先於諸症中擇最甚者為主。而其餘症，每症加專治之藥一二味以成方，則一劑而諸症皆備。以此類推，則合治之法可知矣。藥亦有分合焉，有一病而合數藥以治之者，閱古聖人製方之法自知；有數病而一藥治之者，閱本草之主治自知。為醫者，無一病不窮究其因，無一方不洞悉其理，無一藥不精通其性，庶幾可以自信，而不枉殺人矣。

發汗不用燥藥論

驅邪之法，惟發表、攻裏二端而已，發表所以開其毛孔，令邪從汗出也。當用至輕至淡芳香清冽之品，使邪氣緩緩從皮毛透出，無犯中焦，無傷津液，仲景麻黃桂枝等湯是也。然猶恐其榮中陰氣，為風火所煽而銷耗於內，不能滋潤和澤，以托邪於

外。於是又啜薄粥以助胃氣，以益津液，此服桂枝湯之良法。凡發汗之方，皆可類推。汗之必資於津液如此，後世不知，凡用發汗之方，每專用厚朴、葛根、羌活、白芷、蒼朮、豆蔻等溫燥之藥。即使其人津液不虧，內既為風火所熬，又復為燥藥所燄，則汗從何生？汗不能生，則邪無所附而出。不但不出，邪氣反為燥藥鼓動，益復橫肆，與正氣相亂。邪火四布，津液益傷，而舌焦唇乾，便閉目赤。種種火象自生，則身愈熱，神漸昏，惡症百出。若再發汗，則陽火盛極，動其真陰，腎水來救，元陽從之，大汗上洩，亡陽之危症生矣。輕者亦成痙症，遂屬壞病難治。故用燥藥發汗而殺人者，不知凡幾也。此其端開於李東垣，其所著書立方，皆治溼邪之法，與傷寒雜感無涉。而後人宗其說，以治一切外感之症，其害至今亦甚。況治溼邪之法，亦以淡滲為主，如豬苓、五苓之類，亦無以燥勝之者。蓋溼亦外感之邪，總宜驅之外出，而兼以燥濕之品。斷不可專用勝濕之藥，使之內攻，致邪與正爭而傷元氣也。至於中寒之證，亦先以發表為主，無竟用熱藥以勝寒之理。必其寒氣乘虛陷入而無出路，然後以薑附回其陽，此仲景用理中之法也。今乃以燥藥發雜感之汗，不但非古聖之法，并誤用東垣之法。醫道失傳，只此淺近之理尚不知，何況深微者乎。

病不可輕汗論

治病之法，不外汗下二端而已。下之害人，其危立見。故醫者病者皆不敢輕投。至於汗多亡陽而死者，十有三二雖死而人不覺也。何則？凡人患風寒之疾，必相戒，以為寧暖無涼。病者亦重加覆護，醫者亦云服藥必須汗出而解。故病人之求得汗，人人以為當然也。秋冬之時，過暖尚無大害。至於盛夏初秋，天時暑燥，衛氣開而易洩。更加閉戶重衾，復投發散之劑，必至大汗不止，而陽亡矣。又外感之疾，汗未出之時，必煩悶惡熱。及汗大出之後，衛氣盡洩，必陽衰而惡寒。始之暖覆，猶屬勉強，至此時雖欲不覆而不能，愈覆愈汗，愈汗愈寒。直至汗出如油，手足厥冷，而病不可為矣。其死也，神氣甚清，亦無痛苦。病者醫者，及旁觀之人，皆不解其何故而忽死，惟有相顧噩然而已。我見甚多，不可不察也。總之，有病之人，不可過涼，亦不宜太暖，無事不可令汗出。惟服藥之時，宜令小汗。仲景服桂枝湯法云：服湯已溫覆令微似汗，不可如水淋漓。此其法也。至於亡陽未劇，尤可挽回，傷寒論中真武、理中、四逆等法可考。若已脫盡，無可補救矣。又盛暑之時，病者或居樓上，或臥近灶之所。無病之人，一立其處，汗出如雨；患病者必至時時出汗，即不亡陽，亦必陰竭而死。雖無移徙之處，必擇一席稍涼之地而處之，否則神丹不救也。

傷風難治論

凡人偶感風寒，頭痛發熱，咳嗽涕出，俗語謂之傷風，非傷寒論中所云之傷風，乃時行之雜感也。人皆忽之，不知此乃至難治之疾，生死之所關也。蓋傷風之疾，由皮毛以入於肺，肺為嬌藏，寒熱皆所不宜。太寒則邪氣凝而不出，太熱則火燔金而動血，太潤則生痰飲，太燥則耗精液，太洩則汗出而陽虛，太澀則氣閉而邪結。并有視為微疾，不避風寒，不慎飲食，經年累月，病機日深。或成血證，或成肺痿，或成哮喘，或成怯弱，比比皆然，誤治之害，不可勝數。諺云：傷風不醒變成勞。至言也。然則治之何如？一驅風，蘇葉、荊芥之類；二消痰，半夏、象貝之類；三降氣，蘇子、前胡之類；四和榮衛，桂枝、白芍之類；五潤津液，蔓仁、元參之類；六養血，當歸、阿膠之類；七清火，黃芩、山梔之類；八理肺，桑皮、大力子之類。八者隨其症之輕重而加減之，更加以避風寒，戒辛酸，則庶幾漸愈，否則必成大病。醫者又加以升提辛燥之品，如桔梗、乾薑之類。不效，即加以酸收，如五味子之類，則必見血。既見血，隨用熟地、麥冬，以實其肺，即成勞而死。四十年以來，我見以千計矣，傷哉。

攻補寒熱同用論

虛症宜補，實症宜瀉，盡人而知之者。然或人虛而症實，如弱體之人，冒風傷食之類；或人實而症虛，如強壯之人，勞倦亡陽之類；或有人本不虛，而邪深難出；又有人已極虛而外邪尚伏。種種不同，若純用補，則邪氣益固；純用攻，則正氣隨脫，此病未愈，彼病益深。古方所以有攻補同用之法，疑之者曰：兩藥異性，一水同煎，使其相制，則攻者不攻，補者不補，不如勿服；若或兩藥不相制，分途而往，則或反補其所當攻，攻其所當補，則不惟無益，而反有害，是不可不慮也。此正不然，蓋藥之性，各盡其能，攻者必攻強，補者必補弱，猶掘坎於地，水從高處流下，必先盈坎而後進，必不反向高處流也。如大黃與人參同用，大黃自能逐去堅積，決不反傷正氣；人參自能充益正氣，決不反補邪氣。蓋古人製方之法，分經別藏，有神明之道焉。如瘧疾之小柴胡湯，瘧之寒熱往來，乃邪在少陽，木邪侮土，中宮無主，故寒熱無定。於是用柴胡以驅少陽之邪，柴胡必不犯脾胃；用人參以健中宮之氣，人參必不入肝膽。則少陽之邪自去，而中土之氣自旺，二藥各歸本經也。如桂枝湯，桂枝走衛以祛風，白芍走榮以止汗，亦各歸本經也。以是而推，無不盡然。試以神農本草諸藥主治之說細求之，自無不得矣。凡寒熱兼用之法，亦同此義。故天下無難治之症，後世醫者，不明此理，藥惟一途，若遇病情稍異，非顧此失彼，即游移浮泛，無往而非棘手之病矣。但此必本於古人製方成法而神明之。若竟私心自用，攻補寒熱雜亂不倫，是又殺人之術也。

臨病人問所便論

病者之愛惡苦樂，即病情虛實寒熱之徵。醫者望免切脈而知之，不如其自言之為尤真也。惟病者不能言之處，即言而不知其所以然之故，則賴醫者推求其理耳。今乃病者所自知之病，明明為醫者言之，則醫者正可因其言而知其病之所在以治之。乃不以病人自知之真對症施治，反執己之偏見強制病人，未有不誤人者。如傷寒論中云：能食者為中風，不能食者為中寒。則傷寒內中風之症，未嘗禁其食也。乃醫者見為傷寒之症，斷不許食。凡屬感症，皆不許其食。甚有病已半愈，胃虛求食，而亦禁之，以至因餓而死者。又傷寒論云：欲飲水者，稍稍與之。蓋實火煩渴，得水則解，未嘗禁冷水也。乃醫家凡遇欲冷飲之人，一概禁止，并有伏暑之病，得西瓜而即愈者，病人研求欲食，亦斷絕不與，至煩渴而死。如此之類，不可枚舉。蓋病者之性情氣體，有能受溫熱者，有能受寒涼者，有不受補者，有不禁攻者，各有不同，乃必強而從我意見。況醫者之意見，亦各人不同，於是治病之法，無一中肯者矣。《內經》云：臨病人問所便。蓋病人之所便，即病情真實之所在。如身大熱而反欲熱飲，則假熱而真寒也；身寒戰而反欲寒飲，是假寒而真熱也。以此類推，百不失一。而世之醫者，偏欲與病人相背何也？惟病人有所嗜好而與病相害者，則醫者宜開導之。如其人本喜酸，或得嗽症，則酸宜忌；如病人本喜酒，得溼病則酒宜忌之類，此則不可縱欲以益其疾。若與病症無礙，而病人之所喜，則從病人之便，即所以治其病也。此《內經》辨症之精義也。

治病不必顧忌論

凡病人或體虛而患實邪，或舊有他病與新病相反，或一人兼患二病。其因又相反，或內外上下各有所病，醫者躊躇束手，不敢下藥，此乃不知古人制方之道者也。古人用藥，惟病是求，藥所以制病，有一病則有一藥以制之。其人有是病，則其藥專至于病所而驅其邪，決不反至無病之處以為禍也。若留其病不使去，雖強壯之人，遷延日久，亦必精神耗竭而死，此理甚易明也。如怯弱之人，本無攻伐之理，若或傷寒而邪入陽明，則仍用硝黃下藥，邪去而精氣自復；如或懷妊之婦，忽患癥瘕，必用桃仁、大黃以下其瘕，瘀去而胎自安；或老年及久病之人，或宜發散，或宜攻伐，皆不可因其血氣之衰而兼用補益。如傷寒之後食復、女勞復，仲景皆治其食，清其火，並不因病後而用溫補。惟視病之所在而攻之，中病即止，不復有所顧慮。故天下無棘手之病，惟不能中病，或偏或誤或太過，則不病之處亦傷，而人危矣。俗所謂有病病當之，此歷古相傳之法也。故醫者當疑難之際，多所顧忌，不敢對症用藥者，皆視病不明，辨症不的，審方不真，不日古聖之精義者也。

病深非淺藥能治論

天下有治法不誤，而始終無效者，此乃病氣深痼，非泛然之方藥所能愈也。凡病在皮毛榮衛之間，即使病勢極重，而所感之位甚淺，邪氣易出。至於藏府筋骨之痼疾，如勞怯、痞隔、風痺、痿厥之類，其感非一日。其邪在藏府筋骨，如油之入麵，與正氣相併，病家不知，屢易醫家。醫者見其不效，雜藥亂投，病日深而元氣日敗，遂至不救，不知此病非一二尋常之方所能愈也。今之集方書者，如風痺大症之類，前錄古方數首，後附以通治之方數首，如此而已。此等治法，豈有愈期？必當遍考此病之種類，與夫致病之根源，及變遷之情狀，并詢其歷來服藥之誤否。然後廣求古今以來治此症之方，選擇其內外種種治法，次第施之。又時時消息其效否，而神明變通之，則痼疾或有可愈之理。若徒執數首通治之方，屢試不效，其計遂窮，未有不誤者也。故治大症，必學問深博，心思精敏，又專心久治，乃能奏效。世又有極重極久之病，諸藥罔效，忽服極輕淡之方而愈。此乃其病本有專治之方，從前皆係誤治，忽遇對症之藥，自然應手而痊也。

愈病有日期論

治病之法，自當欲其速愈。世之論者，皆以為治早而藥中病則愈速，治緩而藥不中病則愈遲，此常理也。然亦有不論治之遲早，而愈期有一定者。《內經》藏氣法時論云：夫邪氣之客於身也，以勝相加，至其所生而愈，至其所不勝而甚，至其所生而持，自得其位而起。其他言病愈之期不一。傷寒論云：發於陽者七日愈，發於陰者六日愈。又云：風家表解而不了了者，十二日愈。此皆宜靜養調攝以待之，不可亂投藥石。若以其不愈，或多方以取效，或更用重劑以希功，即使不誤，藥力勝而元氣反傷；更或有不對症之藥，不惟無益，反有大害，此所宜知也。況本原之病，必待其精神漸復，精神豈有驟長之理？至於外科，則起發成膿生肌收口，亦如痘症有一定之日期，治之而誤，固有遷延生變者，若欲強之有速效，則如揠苗助長，其害有不可勝言者，乃病家醫家皆不知之。醫者投藥不效，自疑為未當，又以別方試之，不知前方實無所害，特時未至耳，乃反誤試諸藥，愈換而病愈重。病家以醫者久而不效，更換他醫，他醫遍閱前方，知其不效，亦復更換他藥，愈治愈遠，由是斷斷不死之病亦不救矣。此皆由不知病愈有日期之故也。夫病家不足責，為醫者豈可不知，而輕以人嘗試乎？若醫者審知之，而病家必責我以近效，則當明告之，故決定所愈之期。倘或不信，必欲醫者另立良方，則以和平輕淡之藥，姑以應病者之求，待其自愈。如更不信，則力辭之，斷不可徇人情而至於誤人。如此則病家一時或反怨謗，以後其言果驗，則亦知我識高而品崇矣。

治病必考其驗否論

天下之事，惟以口舌之爭而無從考其信否者，則是非難定。若夫醫則有效驗之可徵，知之最易。而為醫者，自審其工拙亦最易，然而世之擇醫者與為醫者，皆憤憤而莫之辨，何也？古人用藥，苟非宿病痼疾，其效甚速。《內經》云：一劑知，二劑已。又云：覆杯而臥。傷寒論云：一服愈者，不必盡劑。可見古人審病精而用藥當，未有一二劑而效者。故治病之法，必宜先立醫案，指為何病，所本何方，方中用某藥專治某症，其論說本之何書，服此藥後於何時減去所患之何症。倘或不驗，必求所以不驗之故，而更思必效之法；或所期之效不應，反有他效，必求其所以致他效之故。又或反增他症，或病反重，則必求所以致害之故，而自痛懲焉。更復博考醫書，期於必愈而止。若其病本不能速效，或其病祇可小效，或竟不可治，亦必豫立醫案，明著其說，然後立方，不得冒昧施治。如此自考，自然有過必知，加以潛心好學，其道日進矣。今之醫者，事事反此，惟記方數首，擇時尚之藥數種，不論何病何症，總以此塞責。偶爾得效，自以為功，其或無效，或至於死，亦諉於病勢之常，病家亦相循為固然，全不一怪。間有病家於未服藥之前，問醫者服此藥之後，效驗若何。醫者答云，且看服後何如，豈有預期之理，病家亦唯唯自以為失言，何其愚也。若醫者能以此法自考，必成良醫，病家以此法考醫者，必不為庸醫之所誤，兩有所益也。

防微論

病之始生，淺則易治，久而深入，則難治。《內經》云：聖人不治已病治未病。夫病已成而藥之，譬猶渴而穿井，鬥而鑄兵，不亦晚乎。傷寒論序云：時氣不和，便當早言，尋其邪由及在腠理，以時治之，罕有不愈。患人忍之數日乃說，邪氣入臟，則難可制。昔扁鵲見齊桓公云：病在腠理。三見之後，則已入臟，不可治療而逃矣。歷聖相傳，如同一轍。蓋病之始入，風寒既淺，氣血臟腑未傷，自然治之甚易；至於邪氣深入，則邪氣與正氣相亂，欲攻邪則礙正，欲扶正則助邪，即使邪漸去，而正氣已不支矣。若夫得病之後，更或勞動感風傷氣傷食，謂之病後加病，尤極危殆。所以人之患病，在客館道途得者，往往難治。非所得之病獨重也，乃既病之後，不能如在家之安適，而及早治之；又復勞動感冒致病，深入而難治也。故凡人少有不適，必當即時調治，斷不可忽為小病，以致漸深；更不可勉強支持，使病更增，以貽無窮之害。此則凡人所當深省，而醫者亦必詢明其得病之故，更加意體察也。

知病必先知症論

凡一病必有數症。有病同症異者，有症同病異者，有症與病相因者，有症與病不相

因者。蓋合之則曰病，分之則曰症。古方以一藥治一症，合數症而成病，即合數藥而成方。其中亦有以一藥治幾症者，有合幾藥而治一症者。又有同此一症，因不同用藥亦異，變化無窮。其淺近易知者，如吐逆用黃連、半夏，不寐用棗仁、茯神之類，人皆知之。至於零雜之症，如《內經》所載喘惋噫語，吞欠噎嘔，笑泣目瞑，噎乾心懸善恐，涎下涕出，齧脣齧舌，善忘善怒，喜握多夢，嘔酸魄汗等症，不可勝計。或由司天運氣，或由臟府生剋，或由邪氣傳變，《內經》言之最詳。後之醫者，病之總名亦不能知，安能於一病之中，辨明眾症之淵源。即使病者身受其苦，備細言之，而彼實茫然不知古人以何藥為治，仍以泛常不切之品應命。并有用相反之藥以益其疾者，此病者之所以無門可告也。學醫者當熟讀《內經》，每症究其緣由，詳其情狀，辨其異同，審其真偽，然後遍考方書本草，詳求古人治法。一遇其症，應手輒愈，不知者以為神奇，其實古聖皆有成法也。

補藥可通融論

古人病愈之後，即令食五穀以養之，則元氣自復，無所謂補藥也。神農、仲景之書，豈有補益之方哉？間有別載他書者，皆託名也。自唐千金翼等方出，始以養性補益等各立一門，遂開後世補養服食之法。以後醫家凡屬體虛病後之人，必立補方以為調理善後之計。若富貴之人，則必常服補藥，以供勞心縱欲之資。而醫家必百計取媚，以順其意。其藥專取貴重辛熱為主，無非參、朮、地、黃、桂、附、鹿茸之類，託名秘方異傳。其氣體合宜者，一時取效，久之必得風痺陰涸等疾，隱受其害，雖死不悔。此等害人之說，固不足論。至體虛病後補藥之方，自當因人而施，視藏府之所偏而損益之。其藥亦不外陰陽氣血，擇和平之藥數十種，相為出入，不必如治病之法，一味不可移易也。故立方只問其陰陽藏府何者專重而已。況膏丸合就，必經月經時而後服完，若也每日視脈察色而後服藥，則必須一日換一丸方矣。故凡服補藥，皆可通融者也。其有神其說，過為艱難慎重，取貴僻之藥，以為可以卻病長生者，非其人本愚昧，即欲以之欺人耳。

輕藥愈病論

古諺有不服藥為中醫之說，自宋以前已有之。蓋因醫道失傳，治人多誤，病者又不能辨醫之高下，故不服藥，雖不能愈病，亦不至為藥所殺。況病苟非死症，外感漸退，內傷漸復，亦能自愈，故云中醫，此過於小心之法也。而我以為病之在人，有不治自愈者，有不治臨自者，有不治竟不愈而死者。其自愈之疾，誠不必服藥，若難愈及不愈之疾，固當服藥。乃不能知醫之高下，藥之當否，不敢以身嘗試，則莫若擇平易輕淺有益無損之方，以備酌用。小誤亦無害，對病有奇功，此則不止於中

醫矣。如偶感風寒，則用蔥白蘇葉湯取微汗；偶傷飲食，則用山楂、麥芽等湯消食；偶感暑氣，則用六一散、廣藿湯清暑；偶傷風熱，則用燈心竹葉湯清火；偶患腹瀉，則用陳茶佛手湯和腸胃。如此之類，不一而足，即使少誤，必無大害。又有其藥似平常，而竟有大誤者，不可不知。如腹痛嘔逆之症，寒亦有之，熱亦有之，暑氣觸穢亦有之。或見此症而飲以生薑湯，如果屬寒，不散寒而用生薑熱性之藥，至寒氣相鬥，已非正治，然猶有得效之理。其餘三症，飲之必危。曾見有人中暑而服濃薑湯一碗，覆杯即死。若服紫蘇湯，寒即立散，暑熱亦無害。蓋紫蘇性發散，不拘何症，皆能散也。故雖極淺之藥，而亦有深義存焉，此又所宜慎也。凡人偶有小疾，能擇藥性之最輕淡者，隨症飲之，則服藥而無服藥之誤，不服藥而有服藥之功，亦養生者所當深考也。

腹內癰論

古之醫者，無分內外，又學有根柢，故能無病不識。後世內外科既分，則顯然為內症者，內科治之；顯然為外症者，外科治之。其有病在腹中，內外未顯然者，則各執一說，各擬一方，歷試諸藥，皆無效驗，輕者變重，重者即殞矣。此等症，不特外科當知之，即內科亦不可不辨明真確，知非己責，即勿施治，毋至臨危束手，而後委他人也。腹內之癰有數症，有肺癰，有肝癰，有胃脘癰，有小腸癰，有大腸癰，有膀胱癰。惟肺癰咳吐腥痰，人猶易辨，餘者或以為痞結，或以為瘀血，或以為寒痰，或以為食積，醫藥雜投，及至成膿，治已無及。并有不及成膿而死者，病者醫者始終不知，何以致死，比比然也。今先辨明痞結瘀血寒痰食積之狀。凡痞結瘀血，必有所因，且由漸而成寒痰，則痛止無定，又必另現痰症。食積則必有受傷之日，且三五日後大便通即散，惟外症則痛有常所，而遷延益甚。金匱云：諸脈浮數，應當發熱，而反淅淅惡寒，若有痛處，當發其癰，以手按腫上熱者有膿，不熱者無膿。此數句乃內癰真諦也。又云：腸癰之為病，身甲錯，腹皮急，按之濡如腫狀，腹無積聚，身無熱是也。若肝癰則脅內隱隱痛，日久亦吐膿血；小腸癰與大腸相似，而位略高；膀胱癰則痛在少腹之下近毛際，著皮即痛，小便亦艱而痛；胃脘癰則有虛實二種，其實者易消，若成膿必大吐膿血而愈，惟虛症則多不治，先胃中痛脹，久而必下漸高，其堅如石，或有寒熱，飲食不進，按之尤痛，形體枯瘦，此乃思慮傷脾之症，不待癰成即死。故凡腹中有一定痛處，惡寒倦臥不能食者皆當審察，防成內癰。甚毋因循求治於不明之人，以至久而膿潰，自傷其生也。

圍藥論

外科之法，最重外治，而外治之中，尤重圍藥。凡毒之所最忌者，散大而頂不高。

蓋人之一身，豈能無七情六慾之伏火，風寒暑溼之留邪，食飲痰涎之積毒？身無所病，皆散處退藏，氣血一聚，而成癰腫。諸邪四面皆會，惟圍藥能截之，使不併合，則周身之火毒不至矣。其已聚之毒，不能透出皮膚，勢必四布為害，惟圍藥能束之，使不散漫，則氣聚而外洩矣。如此則形小頂高，易膿易潰矣。故外治中之圍藥，較之他藥為特重。不但初起為然，即成膿收口，始終賴之，一日不可缺。若世醫之圍藥，不過三黃散之類，每試不效，所以皆云圍藥無用。如有既破之後，而仍用圍藥者，則群然笑之。故極輕之毒，往往至於散起而不可收拾者，皆不用圍藥之故也。至於圍藥之方，亦甚廣博，大段以消痰、拔毒、束肌、收火為主。而寒熱攻提和平猛厲，則當隨症去取。世人不深求至理，而反輕議圍藥之非，安望其術之能工也。

《難經》論

《難經》非經也。以經文之難解者，設為問難以明之，故曰《難經》，言以經文為難而釋之也。是書之旨，蓋欲推本經旨，發揮至道，剖晰疑義，垂示後學，真讀《內經》之津梁也。但其中亦有未盡善者，其問答之詞，有即引經文以釋之者。經文本自明顯，引之或反遺其要，以至經語反晦。或則無所發明，或則與兩經相背，或則以此誤彼，此其所短也。其中有自出機杼，發揮妙道，未嘗見於《內經》，而實能顯《內經》之奧義，補《內經》之所未發，此蓋別有師承，足與《內經》並垂千古。不知創自越人乎？抑上古亦有此書，而越人引以為證乎？自隋唐以來，其書盛著尊崇之者固多，而無能駁正之者。蓋業醫之輩，讀《難經》而識其大義，已為醫道中傑出之流，安能更深考《內經》，求其異同得失乎？古今流傳之載籍，凡有舛誤，後人無敢議者，比比然也，獨《難經》乎哉？餘詳余所著《難經》經釋中。

傷寒論論

仲景傷寒論編次者，不下數十家，因致聚訟紛紜，此皆不知仲景作書之旨故也。觀傷寒敘所述，乃為庸醫誤治而設，所以正治之法，一經不過三四條，餘皆救誤之法，故其文亦變動不居。讀傷寒論者，知此書皆設想懸擬之書，則無往不得其義矣。今人必改叔和之次序，或以此條在前，或以此條在後，或以此症因彼症而生，或以此經因彼經而變，互相詬厲。孰知病變萬端，傳經無定，古人因病以施方，無編方以待病。其原本次序既已散亡，庶幾叔和所定為可信，何則？叔和序例云：今搜採仲景舊論，錄其症候診脈聲色，對病真方，有神驗者，擬防世急。則此書乃叔和所搜集，而世人輒加辨駁，以為原本不如此。抑思苟無叔和，安有此書？且諸人所編，果能合仲景原文否耶？夫六經現症，有異有同，後人見陽經一症雜於陰經之中，

以為宜改入陽經之內，不知陰經亦有此症也。人各是其私，反致古人圓機活法，泯沒不可問矣！凡讀書能得書中之精義要訣，歷歷分明，則任其顛倒錯亂，而我心自能融會貫通。否則徒以古書紛更互異，愈改愈晦矣。

金匱論

金匱要略，乃仲景治雜病之書也。其中缺略處頗多，而上古聖人以湯液治病之法，惟賴此書之存，乃方書之祖也。其論病皆本於《內經》，而神明變化之；其用藥悉本於神農本草，而融會貫通之；其方則皆上古聖人歷代相傳之經方，仲景間有隨症加減之法；其脈法亦皆《內經》及歷代相傳之真訣；其治病無不精切周到，無一毫遊移參錯之處，實能洞見本源，審察毫末。故所投必效，如桴鼓之相應，真乃醫方之經也。惜其所載諸病，未能全備，未知有殘缺與否。然諸大症之綱領，亦已粗備。後之學者，以此為經，而參考推廣之，已思過半矣！自此以後之書，皆非古聖相傳之真訣，僅自成一家，不可與金匱並別也。

脈經論

王叔和著脈經，分門別類，條分縷晰。其原亦本《內經》，而漢以後之說，一無所遺，其中旨趣，亦不能畫一，使人有所執持。然其匯集群言，使後世有所考見，亦不可少之作也。愚按脈之為道，不過驗其血氣之盛衰寒熱，及邪氣之流在何經何藏，與所現之症參觀互考，以究其生剋順逆之理，而後吉凶可憑。所以《內經》、《難經》及仲景之論脈，其立論反若甚疏，而應驗如神。若執脈經之說以為某病當見某脈，某脈當得某病，雖《內經》亦間有之，不如是之拘泥繁瑣也。試而不驗，於是或咎脈之不準，或咎病之非真，或咎方藥之不對症，而不知皆非也。蓋病有與脈相合者，有與脈不相合者，兼有與脈相反者。同一脈也，見於此症為宜，見於彼症為不宜；同一症也，見某脈為宜，見某脈為不宜。一病可見數十脈，一脈可現數百症，變動不拘。若泥定一說，則從脈而症不合，從症而脈又不合，反令人徬徨無所適從。所以古今論脈之家，彼此互異，是非各別，人持一論，得失相半，總由不知變通之精義，所以愈密而愈疏也。讀脈經者，知古來談脈之詳密如此，因以考其異同，辨其得失，審其真偽，窮其變通，則自有心得。若欲泥脈以治病，必至全無把握。學者必當先參於《內經》、《難經》及仲景之說而貫通之，則胸中先有定見。後人之論，皆足以廣我之見聞，而識力愈真，此讀脈經之法也。

千金方外臺論

仲景之學，至唐而一變。仲景之法病，其論臟府經絡，病情傳變，悉本《內經》。而其所用之方，皆古聖相傳之經方，並非私心自造，間有加減，必有所本。其分兩輕重，皆有法度。其藥悉本於《神農本草》，無一味游移假借之處。非此方不能治此病，非此藥不能成此方，精微深妙，不可思議。藥味不過五六品，而功用無不周。此乃天地之化機，聖人之妙用，與天地同不朽者也。《千金方》則不然，其所論病，未嘗不依《內經》，而不無雜以後世臆度之說。其所用方，亦皆採擇古方，不無兼取後世偏雜之法。其所用藥，未必全本於《神農》，兼取雜方單方及通治之品。故有一病而立數方，亦有一方而治數病。其藥品有多至數十味者，其中對症者固多，不對症者亦不少，故治病亦有效有不效。大抵所重，專在於藥，而古聖製方之法不傳矣。此醫道之一大變也。然其用意之奇，用藥之巧，亦自成一家，有不可磨滅之處。至唐王燾所集《外臺》一書，則纂集自漢以來諸方，匯萃成書，而歷代之方，於焉大備。但其人本非專家之學，故無所審擇以為指歸，乃醫方之類書也。然唐以前之方，賴此書以存，其功亦不可泯。但讀之者，苟胸中無成竹，則眾說紛紜，群方淆雜，反茫然失其所據。古讀《千金》、《外臺》者，必精通於《內經》、仲景、本草等書，胸中先有成見，而後取其長而舍其短，則可資我博採之益。否則反亂人意，而無所適從。嗟乎！《千金》、《外臺》且然，況後世偏駁雜亂之書，能不惑人之心志哉？等而下之，更有無稽杜撰之邪書，尤不足道矣。

《活人書》論

宋人之書，能發明《傷寒論》，使人有所執持而易曉，大有功於仲景者，《活人書》為第一。蓋《傷寒論》不過隨舉六經所現之症以施治，有一症而六經皆現者，並有一症而治法迥別者，則讀者茫無把握矣。此書以經絡病因傳變疑似，條分縷晰，而後附以諸方治法，使人一覽了然，豈非後學之津梁乎？其書獨出機杼，又能全本經文，無一字混入己意，豈非好學深思，述而不作，足以繼往開來者乎？後世之述《傷寒論》者，唐宋以來，已有將經文刪改移易，不明不貫。至近代前《條辨》、《尚論編》等書，又復顛倒錯亂，各逞意見，互相辨駁，總由分症不清，欲其強合，所以日就支離。若能參究此書，則任病情之錯綜反覆，而治法仍歸一定，何必聚訟紛紜，致古人之書，愈講而愈晦也。

《太素脈》論

診脈以之治病，其血氣之盛衰，及風寒暑濕之中人，可驗而知也。，乃相傳有《太

素脈》之說，以候人之壽夭窮通，知愚善惡，纖悉皆備。夫脈乃氣血之見端，其長而堅厚者，為壽之徵。其短小而薄弱者，為夭之徵。清而有神，為智之徵。濁而無神，為愚之徵。理或宜然。若善惡已不可知，窮通則與脈何與？然或得壽之脈，而其人或不謹於風寒勞倦，患病而死；得夭之脈，而其人愛護調攝，得以永年。又有血氣甚清而神志昏濁者，形質甚濁而神志清明者。即壽夭知愚，亦不能皆驗，況其他乎？又書中更神其說，以為能知某年得某官，某年得財若干，父母何人，子孫何若，則更荒唐矣！天下或有習此術而言多驗者，此必別有他術以推測而倖中，借此以神其說耳。若盡於脈見之，斷斷無是理也。

婦科論

婦人之疾，與男子無異，惟經期胎產之病不同，且多癥瘕之疾。其所以多癥瘕之故，亦以經帶胎產之血易於凝滯，故較之男子為多。故古人名婦科謂之帶下醫，以其病總屬於帶下也。凡治婦人，必先明衝任之脈。衝脈起於氣街（在毛際兩旁），並少陰之經，挾臍上行，至胸中而散。任脈起於中極之下（臍旁四寸），以上毛際，循腹裏，上關元。又云：衝任脈皆起於胞中，上循背裏，為經脈之海。此皆血之所從生，而胎之所由繫。明於衝任之故，則本原洞悉，而後其所生之病，千條萬緒，可以知其所從起。更參合古人所用之方，而神明變化之，則每症必有傳受，不概治以男子泛用之藥，自能所治輒效矣。至如世俗相傳之邪說，如胎前宜涼，產後宜溫等論。夫胎前宜涼，理或有之，若產後宜溫，則脫血之後，陰氣大傷，孤陽獨熾；又瘀血未淨，結為蘊熱，乃反用薑桂等藥，我見時醫以此殺人無數。觀仲景先生於產後之疾，以石膏、白薇、竹茹等藥治之，無不神效。或云：產後瘀血，得寒則凝，得熱則行，此大謬也。凡瘀血凝結，因熱而凝者，得寒降而解；因寒而凝者，得熱降而解。如桃仁承氣湯，非寒散而何？未聞此湯能凝血也。蓋產後瘀血熱結為多，熱瘀成塊，更益以熱，則煉成乾血，永無解散之日。其重者，陰涸而即死；輕者，成堅痞癰勞等疾，惟實見其真屬寒氣所結之瘀，則宜用溫散。故凡治病之法，不本於古聖，而反宗後人之邪說，皆足以害人。諸科皆然，不獨婦科也。

痘科論

今天下之醫法失傳者，莫如痘疹。痘之源，藏於臟腑骨脈，而發於天時。所謂本於臟腑骨脈者，凡人受生之初，陰陽二氣，交感成形。其始因火而動，則必有渣滓未融之處，伏於臟腑骨脈之中，此痘之本源也。然外無感召，則伏而不出，及天地寒暑陰陽之氣，沴戾日積，與人身之臟腑氣血相應，則其毒隨之而越，此發於天時者也。而天時有五運六氣之殊，標本勝復之異。氣體既稟受不同，感發又隨時各別，

則治法必能通乎造化之理而補救之，此至精至微之術也。奈何以寒涼伐之，毒藥劫之哉？夫痘之源，不外乎火，固也。然《內經》云：火鬱則發之。其遇天時炎熱，火甚易發者，清解固宜。若冬春之際，氣為寒束，則不起發；發而精血不充，則無漿。漿而精血不繼，即不靨。則溫散提托補養之法，缺一不可，豈得概用寒涼？至其用蚯蚓、桑蟲、全蠍等毒藥，為禍尤烈。夫以毒攻毒者，謂毒氣內陷，一時不能托出，則借其力以透發之。此皆危篤之症，千百中不得一者，乃視為常用之藥，則無毒者反益其毒矣。病家因其能知死期，故死而不怨。孰知服彼之藥，無有不死，非其識見之高，乃其用藥之靈也。故症之生死，全賴氣血。當清火解毒者，則清火解毒；當培養氣血者，則溫托滋補，百不失一矣。嗚呼！謬說流傳，起於明季，至今尤甚。惟以寒藥數品，按日定方，不效，則繼以毒藥，如此而已。夫以至變至微之病，而立至定至粗之法，於是群以為痘科最易，不知殺人亦最多也。

附種痘說：種痘之法，此仙傳也。有九善焉：凡物欲其聚，惟痘不欲其聚，痘未出而強之出，則毒不聚，一也。凡物欲其多，痘欲其少，強之出必少，二也。凡物欲其大，痘欲其小，強之出必小，三也。不感時痘之戾氣，四也。擇天地溫和之日，五也。擇小兒無他病之時，六也。其痘苗皆取種出無毒之善種，七也。凡痘必漿成十分而後毒不陷，種痘之漿五分以上即無害，八也。凡痘必十二朝成靨，并有延至一月者，種痘則九朝已回，九也。其有種而死者，深用悔恨。不知種而死者，則自出斷無不死之理，不必悔也。至於種出危險之痘，或生痘毒，此則醫家不能用藥之故。種痘之人，更能略知治痘之法，則尤為十全矣。

幼科論

幼科古人謂之啞科，以其不能言，而不知病之所在也。此特其一端耳。幼科之病，如變蒸胎驚之類，與成人異者，不可勝舉。非若婦人之與男子異者，止經產數端耳。古人所以另立專科，其說精詳明備。自初生以至成童，其病名不啻以百計。其治法立方，種種各別。又婦人之與男子病相同者，治亦相同。若小兒之與成人，即病相同者，治亦迥異。如傷食之症，反有用巴豆、礞砂。其餘諸症，多用金石峻厲之藥，特分兩極少耳。此古人真傳也！後世不敢用，而以草木和平之藥治之，往往遷延而死。此醫者失傳之故。至於調攝之法，病家能知之者，千不得一。蓋小兒純陽之體，最宜清涼，今人非太煖即太飽。而其尤害者，則在於有病之後，而數與之乳。乳之為物，得熱則堅韌如棉絮。況兒有病，則食乳甚稀，乳久不食，則愈充滿，一與之吮，則迅疾湧出，較平日之下咽更多。前乳未消，新乳復充，填積胃口，化為頑痰，痰火相結，諸脈皆閉而死矣。譬如常人平日食飯幾何，當病危之時，其食與平時不減，安有不死者哉？然囑病家云：乳不可食，則群相詬曰：乳猶水也，食之何害？況兒虛如此，全賴乳養，若復禁乳，則餓死矣。不但不肯信，反將醫者詬罵。其餘之不當食而食，與當食而反不與之食，種種失宜，不可枚舉。醫者豈能坐

守之，事事合節耶？況明理之醫能知調養之法者，亦百不得一。故小兒之所以難治者，非盡不能言之故也。

瘍科論

瘍科之法，全在外治，其手法必有傳授。凡辨形察色，以知吉凶，及先後施治，皆有成法。必讀書臨症二者皆到，然後無誤。其升降圍點，去腐生肌，呼膿止血，膏塗洗熨等方，皆必純正和平，屢試屢驗者，乃能應手而愈。至於內服之方，護心托毒，化膿長肉，亦有真傳，非尋常經方所能奏效也。惟煎方則必視其人之強弱陰陽，而為加減，此則必通於內科之理，全在學問根柢。然又與內科不同。蓋煎方之道相同，而其藥則有某毒主某藥，某症主某方，非此不效，亦另有傳授焉。故外科總以傳授為主，徒恃學問之宏博無益也。有傳授則較之內科為尤易。惟外科而兼內科之症，或其人本有宿疾，或患外症之時，復感他氣，或因外症重極，內傷藏府，則不得不兼內科之法治之。此必平日講於內科之道而通其理，然後能兩全而無失。若不能治其內症，則并外症亦不可救，此則全在學問深博矣。若為外科者不能兼，則當另請名理內科為之定方。而為外科者，參議於其間，使其藥與外症無害，而後斟酌施治，則庶幾兩有所益。若其所現內症，本因外症而生，如痛極而昏暈，膿欲成而生寒熱，毒內陷而脹滿，此則內症皆由外症而生。只治其外症，而內症已愈，此又不必商之內科也。但其道甚微，其方甚眾，亦非淺學者所能知也。故外科之道，淺言之，則惟記煎方數首，合膏圍藥幾料，已可以自名一家；若深言之，則經絡藏腑氣血骨脈之理，及奇病怪疾，千態萬狀，無不盡識。其方亦無病不全，其珍奇貴重難得之藥，亦無所不備。雖遇極奇極險之症，亦了然無疑。此則較之內科為更難，故外科之等級，高下懸殊，而人之能識其高下者，亦不易也。

祝由科論

祝由之法，《內經》賊風篇岐伯曰：先巫知百病之勝，先知其病所從生者，可祝而已也。又移精變氣論，岐伯云：古恬澹之世，邪不能深入，故可移精祝由而已。今人虛邪賊風，內著五藏骨髓，外傷空竅肌膚，所以小病必甚，大病必死，故祝由不能已也。由此觀之，則祝由之法亦不過因其病情之所由，而宣意導氣，以釋疑而解惑。此亦必病之輕者，或有感應之理。若果病機深重，亦不能有效也。古法今已不傳，近所傳符咒之術，間有小效，而病之大者，全不見功。蓋岐伯之時已然，況後世哉？存而不論可也。

獸醫論

禽獸之病，由於七情者少，由於風寒飲食者多，故治法較之人為猶易。夫禽獸之藏府經絡，雖與人殊，其受天地之血氣，不甚相遠，故其用藥亦與人大略相同。但其氣粗血濁，其所飲食，非人之飲食，則藥亦當別有主治，不得盡以治人者治之矣。如牛馬之食，則當用消草之藥；犬豕之食，則當用消糠豆之藥是也。又有專屬之品，如貓宜烏藥，馬宜黃藥之類。而其病亦一獸有一獸獨患之病，此則另有專方主治。餘則與人大段相同。但必劑大而力厚之方，取效為易。其中又有天運時氣之不同，變化多端，亦必隨症加減，此理亦廣博深奧，與治人之術不相上下。今則醫人之醫尚絕傳，況獸醫乎。

四大家論

醫道之晦久矣。明人有四大家之說，指張仲景、劉河間、李東垣、朱丹溪四人，謂為千古醫宗。此真無知妄談也。夫仲景先生，乃千古集大成之聖人，猶儒宗之孔子。河間、東垣，乃一偏之學。丹溪不過斟酌諸家之言，而調停去取，以開學者便易之門。此乃世俗之所謂名醫也，三子之於仲景，未能望見萬一，乃躋而與之並稱，豈非絕倒？如扁鵲、倉公、王叔和、孫思邈輩，則實有師承，各操絕技，然亦僅成一家之言，如儒家漢唐諸子之流，亦斷斷不可與孔子並列，況三人哉？至三人之高下，劉則專崇《內經》，而實不能得其精義；朱則平易淺近，未睹本原；至於東垣，執專理脾胃之說，純用升提香燥，意見偏而方法亂，貽誤後人，與仲景正相反。後世頗宗其說，皆由世人之於醫理全未夢見，所以為所惑也。更可駭者，以仲景有《傷寒論》一書，則以為專明傷寒，《金匱要略》則以為不可依以治病，其說荒唐更甚。吾非故欲輕三子也。蓋此說行，則天下惟知竊三子之緒餘，而不深求仲景之學，則仲景延續先聖之法，從此日衰。而天下萬世，夭扎載途，其害不小，故當亟正之也。

醫家論

醫之高下不齊，此不可勉強者也。然果能盡知竭謀，小心謹慎，猶不至於殺人。更加以詐偽萬端，其害不可窮矣。或立奇方以取異；或用僻藥以惑眾；或用參茸補熱之藥以媚富貴之人；或假託仙佛之方，以欺愚魯之輩；或立高談怪論，驚世盜名；或造假經偽說，瞞人駭俗；或明知此病易曉，偽說彼病以示奇。如冬月傷寒，強加香薷於傷寒方內而愈，以為此暑病也，不知香薷乃其惑人之法也。如本係熱症，強加乾薑於涼藥之內而愈，以為此真寒也，不知彼之乾薑，乃泡過百次而無味者也。

於外科則多用現成之藥，尤不可辨，其立心尤險。先使其瘡極大，令人驚惶而後治之，并有能發不能收以至斃者。又有偶得一方，如五灰膏、三品一條鎗之類，不顧人之極痛，一概用之，哀號欲死，全無憐憫之心。此等之人，不過欲欺人圖利，即使能知一二，亦為私欲所汨沒，安能奏功？故醫者能正其心術，雖學不足，猶不至於害人。況果能虛心篤學，則學日進；學日進則每治必愈，而聲名日起，自然求之者眾，而利亦隨之。若專於求利，則名利必兩失，醫者何苦舍此而蹈彼也？

醫學淵源論

醫書之最古者《內經》，則醫之祖乃岐黃也。然《本草》起於神農，則又在黃帝之前矣。可知醫之起，起於藥也。至黃帝則講夫經絡臟腑之原，內傷外感之異，與夫君臣佐使，大小奇偶之制，神明夫用藥之理。醫學從此大備，然其書講人身臟腑之形，七情六淫之感，與針灸雜法為多，而製方尚少。至伊尹有湯液治病之法，然亦得之傳聞，無成書可考。至扁鵲、倉公，而湯藥之用漸廣。張仲景先生出，而雜病傷寒，專以方藥為治，遂為千古用方之祖。而其方亦俱原本神農、黃帝之精義，皆從古相傳之方，仲景不過集其成耳。自是之後，醫者以方藥為重，其於天地陰陽經絡臟腑之道，及針灸雜術，往往不甚考求。而治病之法，從此一變。唐宋以後，相尋彌甚，至元之劉河間、張潔古等出，未嘗不重《內經》之學，凡論病必先敘經文，而後採取諸家之說，繼乃附以治法，似為得旨。然其人皆非通儒，不能深通經義，而於仲景制方之義，又不能深考其源，故其說非影響即支離，各任其偏，而不歸於中道。其尤偏駁者，李東垣為甚，惟以溫燥脾胃為主，其方亦毫無法度。因當時無真實之學，盜竊虛名，故其教至今不絕。至明之薛立齋，尤浮泛荒謬，猶聖賢之學，變而為腐爛時文，何嘗不曰我明經學古者也。然以施之治天下，果能如唐虞三代者乎？既不知神農、黃帝之精義，則藥性及臟腑經絡之源不明也，又不知仲景制方之法度，則病變及施治之法不審也。惟曰某病則用某方，如不效，改用某方。有一方服至二三十劑，令病者遷延自愈者。胸中毫無把握，惟以簡易為主。自此以降，流弊日甚，而枉死載途矣。安得有參《本草》、窮《內經》、熟《金匱》、《傷寒》者，出而挽救其弊，以全民命乎？其害總由於習醫者皆貧苦不學之人，專以此求衣食，故祇記數方，遂以之治天下之病，不復更求他法，故其禍遂至於此也！

考試醫學論

醫為人命所關，故《周禮》醫師之屬，掌於冢宰，歲終必稽其事而制其食。至宋神宗時，設內外醫學，置教授及諸生，皆分科考察陞補。元亦仿而行之。其考試之文，皆有程式，未知當時得人何如？然其慎重醫道之意，未嘗異也。故當時立方治病

，猶有法度。後世醫者，大概皆讀書不就，商賈無資，不得已而為衣食之計，或偶涉獵肆中，勦襲醫書，或託名近地時醫門下。始則欲以欺人，久之亦自以為醫術不過如此。其誤相仍，其害無盡，岐黃之精義幾絕矣！若欲斟酌古今考試之法，必訪求世之實有師承，學問淵博，品行端方之醫。如宋之教授，令其嚴考諸醫，取其許掛牌行道。既行之後，亦復每月嚴課，或有學問荒疏，治法謬誤者，小則撤牌讀書，大則飭使改業。教授以上，亦如《周禮》醫師之有等。其有學問出眾，治效神妙者，候補教授。其考試之法，分為六科。曰針灸，曰大方，曰婦科，曰幼科兼痘科，曰眼科，曰外科。其能諸科皆通者，曰全科，通一二科者曰兼科，通一科者曰專科。其試題之體有三：一曰論題，出《靈樞》、《素問》，發明經絡藏府、五運六氣、寒熱虛實、補瀉逆從之理。二曰解題，出《神農本草》、《傷寒論》、《金匱藥略》，考訂藥性，病變制方之法。三曰案，自述平日治病之驗否，及其所以用此方治此病之意。如此考察，自然言必本於聖經，治必遵乎古法，學有淵源，而師承不絕矣。豈可聽涉獵杜撰，全無根柢之人，以人命為兒戲乎！

醫非人人可學論

今之學醫者，皆無聊之甚，習此業以為衣食之計耳。孰知醫之為道，乃古聖人所以洩天地之祕，奪造化之權，以救人之死。其理精妙入神，非聰明敏哲之人不可學也。黃帝、神農、越人、仲景之書，文詞古奧，搜羅廣遠，非淵博通達之人不可學也；凡病之情，傳變在於煩刻，真偽一時難辨，一或執滯，生死立判，非虛懷靈變之人不可學也；病名以千計，病症以萬計，臟腑經絡，內服外治方藥之書，數年不能竟其說，非勤讀善記之人不可學也。又《內經》以後，支分派別，人自為師，不無偏駁；更有怪僻之論，鄙俚之說，紛陳錯立，淆惑百端，一或誤信，終身不返，非精鑒確識之人不可學也。故為此道者，必具過人之資，通人之識，又能屏去俗事，專心數年，更得師之傳授，方能與古聖人之心，潛通默契。若今之學醫者，與前數端事事闕反。以通儒畢世不能工之事，乃以全無文理之人，欲煩刻而能之。宜道之所以日喪，而枉死者遍天下也。

名醫不可為論

為醫固難，而為名醫尤難，何則？名醫者，聲價甚高，敦請不易，即使有力可延，又恐往而不遇。即或可遇，其居必非近地，不能旦夕可至。故病家凡屬輕小之疾，不即延治；必病勢危篤，近醫束手，舉家以為危，然後求之，夫病勢而人人以為危，則真危矣。又其病必遷延日久，屢易醫家，廣試藥石，一誤再誤，病情數變，已成壞症。為名醫者，豈真有起死回生之術哉？病家不明此理，以為如此大名，必有回天之力，若亦如他醫之束手，亦何以異於人哉？於是望之甚切，責之甚重。若真能操人生死之權者，則當之者難為情矣。若此病斷然必死，則明示以不治之故，定

之死期，飄然而去，猶可免責，倘此症萬死之中，猶有生機一線，若用輕劑以塞責，致病人萬無生理，則於心不安；若用重劑，以背城一戰，萬一有變，則謗議蜂起，前人誤治之責，盡歸一人。雖當定方之時，未嘗不明白言之。然人情總以成敗為是非，既含我之藥而死，其咎不容諉矣。又或大病差後，元氣虛而餘邪尚伏，善後之圖尤宜深講。病家不知，失於調理，愈後復發，仍有歸咎於醫之未善者，此類甚多。故名醫之治病，較之常醫倍難也。知其難，則醫者固宜慎之又慎；而病家及傍觀之人，亦宜曲諒也。然世又有獲虛名之時醫，到處誤人，而病家反云此人治之而不愈，是亦命也。有殺人之實，無殺人之名，此必其人別有巧術以致之，不在常情之內矣。

邪說陷溺論

古聖相傳之說，揆之於情有至理，驗之於疾有奇效，然天下之人反甚疑焉。而獨於無稽之談，義所難通，害又立見者，人人奉以為典訓，守之不敢失者，何也？其所由來久矣。時醫之言曰：古方不可以治今病。嗟乎！天地之風寒暑濕燥火猶是也，生人七情六慾猶是也，而何以古人用之則生，今人用之則死？不知古人之以某方治某病者，先審其病之確然，然後以其方治之。若今人之所謂某病，非古人之所謂某病也。如風火雜感，症類傷寒，實非傷寒也。乃亦以大劑桂枝湯汗之，重者吐血狂躁，輕者身熱悶亂，於是罪及仲景，以為桂枝湯不可用。不自咎其辨病之不得，而咎古方之誤人，豈不謬乎？所謂無稽之邪說，如深秋不可用白虎。白虎乃傷寒陽明之藥，傷寒皆在冬至以後，尚且用之，何以深秋已不可用？又謂痢疾血症，皆無止法。夫痢血之病，屬實邪有瘀者，誠不可以遽止；至於滑脫空竭，非止不為功，但不可塞其火邪耳？又謂餓不死之傷寒，吃不死之痢疾。夫《傷寒論》中以能食不能食，驗中寒、中風之別，其中以食不食，辨症之法，不一而足。況邪方退，非扶其胃氣，則病變必多。宿飲欲行，非新穀入胃，則腸中之氣必不下達。但不可過用耳。執餓不死之說，而傷寒之禁其食，而餓死者多矣！謂痢疾為吃不殺者，乃指人之患痢，非噤口而能食者，則其胃氣尚強，其病不死，故云。然非謂痢疾之人，無物不可食。執吃不殺之說，而痢疾之過食而死者多矣！此皆無稽之談，不可枚舉。又有近理之說而謬解之者，亦足為害。故凡讀書議論，必審其所以然之故，而更精思歷試，方不為邪說所誤。故聖人深惡夫道聽塗說之人也。

涉獵醫書誤人論

人之死，誤於醫家者十之三，誤於病家者十之三，誤於旁人涉獵醫書者，亦十之三。蓋醫之為道，乃通天徹地之學，必全體明而後可以治一病。若全體不明，而偶得

一知半解，舉以試人，輕淺之病，或能得效；至於重大疑難之症，亦以一偏之見，妄議用藥，一或有誤，生死立判矣。間或偶然倖中，自以為如此大病，猶能見功，益復自信，以後不拘何病，輒妄加議論。至殺人之後，猶以為病自不治，非我之過，於是終身害人而不悔矣。然病家往往多信之者，則有故焉。蓋病家皆不知醫之人，而醫者寫方即去，見有稍知醫理者，議論鑿鑿，又關切異常，情面甚重，自然聽信。誰如彼乃偶然繙閱，及道聽塗說之談，彼亦未嘗審度，從我之說病者，如何究竟，而病家已從之矣。又有文人墨客，及富貴之人，文理本優，偶爾檢點醫書，自以為已有心得，傍人因其平日稍有學問品望，倍加信從。而世之醫人，因自己全無根柢，辨難反出其下，於是深加佩服。彼以為某乃名醫，尚不如我，遂肆然為人治病，愈則為功，死則無罪。更有執一偏之見，恃其文理之長，更著書立說，貽害後世。此等之人，不可勝數。嗟乎！古之為醫者，皆有師承，而又無病不講，無方不通，一有邪說異論，則引經據典以折之，又能實有把持，所治必中，故餘人不得而參其末議。今之醫者，皆全無本領，一書不讀，故涉獵醫書之人，反出而臨乎其下，致病家亦鄙薄醫者，而反信夫涉獵之人，以致害人如此。此其咎，全在醫中之無人，故人人得而操其長短也。然涉獵之人，久而自信益真，始誤他人，繼誤骨肉，終則自誤其身。我見甚多，不可不深省也。

病家論

天下之病，誤於醫家者固多，誤於病家者尤多。醫家而誤，易良醫可也；病家而誤，其弊不可勝窮。有不問醫之高下，即延以治病，其誤一也；有以耳為目，聞人譽某醫，即信為真，不考其實，其誤二也；有平日相熟之人，務取其便，又慮別延他人，覺情面有虧，而其人又叨任不辭，希圖酬謝，古人所謂以性命當人情，其誤三也；有遠方邪人，假稱名醫，高談闊論，欺騙愚人，遂不復詳察，信其欺妄，其誤四也；有因至親密友或勢位之人，薦引一人，情分難卻，勉強延請，其誤五也；更有病家戚友，偶閱醫書，自以為醫理頗通，每見立方，必妄生議論，私改藥味，善則歸己，過則歸人，或各薦一醫，互相毀謗，遂成黨援，甚者各立門戶，如不從己，反幸災樂禍，以期必勝，不顧病者之死生，其誤七也；又或病勢方轉，未收全功，病者正疑見效太遲，忽而讒言蜂起，中道變更，又換他醫，遂至危篤，反咎前人，其誤八也；又有病變不常，朝當桂附，暮當芩連；又有純虛之體，其症反宜用硝黃；大實之人，其症反宜用參朮。病家不知，以為怪僻，不從其說，反信庸醫，其誤九也；又有吝惜錢財，惟賤是取，況名醫皆自作主張，不肯從我，反不若某某等和易近人，柔順受商，酬謝可略。扁鵲云：輕身重財不治。其誤十也。此猶其大端耳。其中更有用參附則喜，用攻劑則懼；服參附而死，則委之命，服攻伐而死，則咎在醫，使醫者不敢對症用藥。更有製藥不如法，煎藥不合度，服藥非其時，更或飲食起居，寒暖勞逸，喜怒語言，不時不節，難以枚舉。小病無害，若大病則有一不合，皆足以傷生。然則為病家者當何如？在謹擇名醫而信任之。如人君之用宰相

，擇賢相而專任之，其理一也。然則擇賢之法若何？曰：必擇其人品端方，心術純正，又復詢其學有根柢，術有淵源，歷考所治，果能十全八九，而後延請施治。然醫各有所長，或今所患非其所長，則又有誤。必細聽其所論，切中病情，和平正大；又用藥必能命中，然後託之。所謂命中者，其立方之時，先論定此方所以然之故，服藥之後如何效驗；或云必得幾劑而後有效，其言無一不驗，此所謂命中也。如此試醫，思過半矣。若其人本無足取，而其說又怪僻不經，或游移恍惚；用藥之後，與其所言全不相應，則即當另覓名家，不得以性命輕試。此則擇醫之法也。

醫者誤人無罪論

人命所關亦大矣。凡害人之命者，無不立有報應。乃今之為名醫者，既無學問，又無師授，兼以心術不正，欺世盜名，害人無算，宜有天罰，以彰其罪。然往往壽考富厚，子孫繁昌，全無殃咎，我始甚不解焉。以後日與病者相周旋，而後知人之誤藥而死，半由於天命，半由於病家，醫者不過依違順命，以成其死，並非造謀之人。故殺人之罪，醫者不受也。何以言之？夫醫之良否，有一定之高下。而病家則於醫之良者，彼偏不信；醫之劣者，反信而不疑。言補益者，以為良醫；言攻散者，以為庸醫；言溫熱者，以為有益；言清涼者，以為傷生。或旁人互生議論，或病人自改方藥，而醫者欲其術之行，勢必曲從病家之意。病家深喜其和順，偶然或愈，醫者自矜其功；如其或死，醫者不任其咎。病家因自作主張，隱諱其非，不復咎及醫人。故醫者之曲從病家，乃邀功避罪之良法也。既死之後，聞者亦相傳以為某人之病，因誤服某人之藥而死，宜以為戒矣。及至自己得病，亦復如此。更有平昔最佩服之良醫，忽然自生疾病，反信平日所最鄙薄之庸醫而傷其生者，是必有鬼神使之，此乃所謂命也。蓋人生死有定數，若必待人之老而自死，則天下皆壽考之人而命無權，故必生疾病，使之不以壽而死。然疾病之輕重不齊，或其人善自保護，則六淫七情之所感甚輕。命本當死，而病淺不能令其死，則命又無權，於是天生此等之醫，分布於天下。凡當死者，少得微疾，醫者必能令其輕者重，重者死。而命之權，於是獨重，則醫之殺人，乃隱然奉天之令，以行其罰，不但無罪，且有微功，故無報也。惟世又有立心欺詐，賣弄聰明，造捏假藥，以欺嚇人，而取其財者，此乃有心之惡，與前所論之人不同。其禍無不立至，我見亦多矣。願天下之人細思之，真鑿鑿可徵，非狂談也。